AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

DIABETES MELLITUS

25 temas · 1 página cada uno

Dislipidemias

10 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días



Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Diagnóstico, Clasificación y Tamizaje de Diabetes

★★☆ 1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY GES 3
★★★ 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS GES 4
★★★ 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) GES 5
★★★ 1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas GES 6
★☆☆ 1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular GES 7

02 Farmacoterapia Oral y Manejo de DM2 en APS

★★★ 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL GES 8
★★★ 2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas GES 9
★★★ 2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 10
★★★ 2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante GES 11
★☆☆ 2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal GES 12

03 Insulinoterapia y Manejo Hospitalario

★★★ 3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio GES 13
★★★ 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis GES 14
★★★ 3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado GES 16
★★☆ 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate GES 17

04 Emergencias Hiperglicémicas Agudas

★★☆ 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) GES 18
★★☆ 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH GES 19
★★☆ 4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato GES 21
★☆☆ 4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea GES 22
★☆☆ 4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia GES 23

05 Complicaciones Crónicas y Dislipidemias

★★☆ 5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector GES 24
★☆☆ 5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES GES 25
★★☆ 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico GES 26
★★☆ 5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas GES 28
★☆☆ 5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis GES 29
★★☆ 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria 30

Números que tienes que saber 32
Fármacos de primera línea 35
GES de la especialidad 36
Plan de repaso de 7 días 38
Índice por prioridad ★ 39

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2

1.02.1.004	Diabetes Mellitus tipo 1	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- **La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto**: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.



ACANTOSIS EN EL CUELLO
High-Yield review, p. 774

ALGORITMO · TIPOS DE DIABETES: ¿LE QUEDA INSULINA AL PÁNCREAS?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

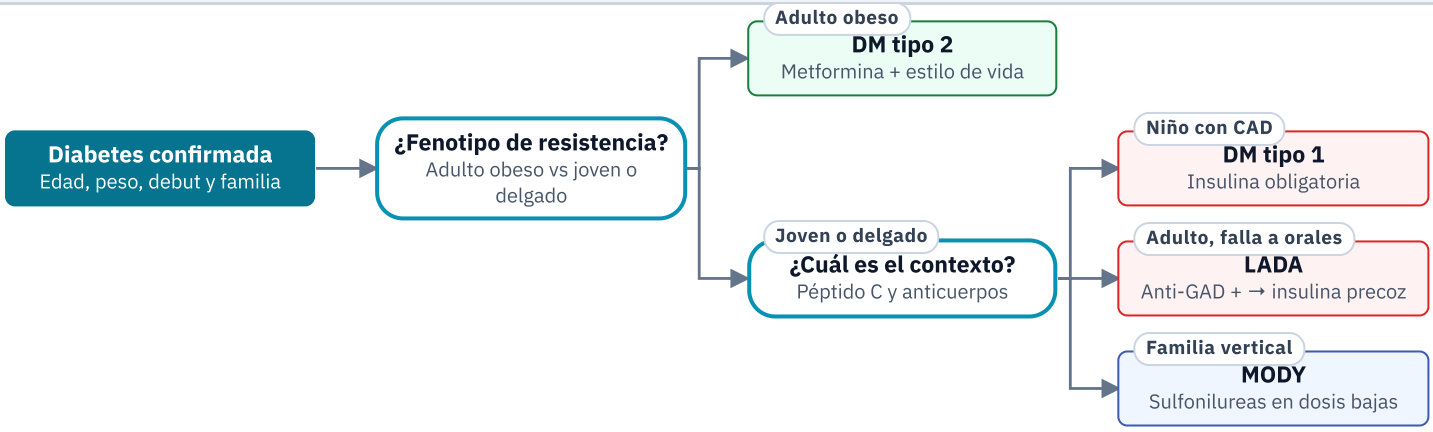


TABLA 1.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DM TIPO 1, DM TIPO 2, LADA Y MODY

CARACTERÍSTICA	DM TIPO 1	DM TIPO 2	LADA (ADULTO)	MODY (GENÉTICA)
Edad habitual de debut	< 20 años (niños/jóvenes)	> 35 - 45 años (adultos)	25 a 50 años	< 25 años
Hábito corporal / IMC	Normopeso o bajo peso	Sobrepeso u Obesidad (> 85%)	Normopeso o leve sobrepeso	Delgado / Normopeso
Herencia y antecedentes	Poligénica / HLA-DR3-DR4	Familiar poligénica alta	Autoinmunidad asociada	Autosómica dominante (3 gen.)
Péptido C sérico	Muy disminuido / Ausente	Elevado o normal	Bajo o descendiendo	Normal o detectable
Anticuerpos (Anti-GAD)	Positivos (> 85-90%)	Negativos	Positivos (patognomónico)	Negativos
Respuesta inicial a HGO	Nula (insulina obligatoria)	Buena (metformina)	Fracaso precoz a HGO	Excelente a Sulfonilureas

TRAMPAS EUNACOM

clase diab-01

TIPO	PERFIL CLÍNICO	LABORATORIO	TRATAMIENTO INICIAL
DM tipo 1	Menor de 20, normo o bajo peso, CAD	Péptido C ausente · anticuerpos +	Insulina obligatoria
DM tipo 2	Adulto con obesidad, acantosis	Péptido C normal o alto · anticuerpos –	Metformina + estilo de vida
LADA	Adulto 25–45, delgado, otra autoinmunidad	Anti-GAD + · péptido C en descenso	Insulina precoz

REGLA DE ORO **Tipo 1: déficit absoluto** — Joven, flaco, cetosis: insulina

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **6–12** (pág. 9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES TIER 3

1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

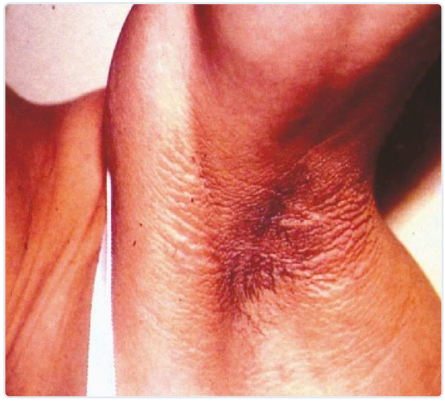
★★★ PRIORIDAD ALTA
21 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2 en Personas de 15 años y más

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2 — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	1.02.4.024	Test de tolerancia a la glucosa — Interpreta y emplea
1.02.4.017	Hemoglobina glicosilada — Interpreta y emplea	1.02.4.016	Glicemia venosa — Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Cuatro criterios**: Ayuno **≥ 126 mg/dL**; PTGO **2h ≥ 200 mg/dL**; HbA1c **≥ 6.5%**; o Glicemia al azar **≥ 200 mg/dL** con síntomas.
- En pacientes asintomáticos, toda glicemia **≥ 126 mg/dL** DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.
- Glicemia casual **≥ 200 mg/dL** con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.
- Glicemia de ayuno entre 100 y **125 mg/dL** se denomina Glicemia de Ayuno Alterada y exige solicitar una PTGO con **75 g**.
- La PTGO diagnostica Intolerancia a la Glucosa si el valor a las **2 horas** es **140–199 mg/dL**, y Diabetes si es **≥ 200 mg/dL**.



ACANTOSIS NIGRICANS
Manual AMIR Dermatología, p. 30

ALGORITMO · DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN EL ADULTO NO EMBARAZADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

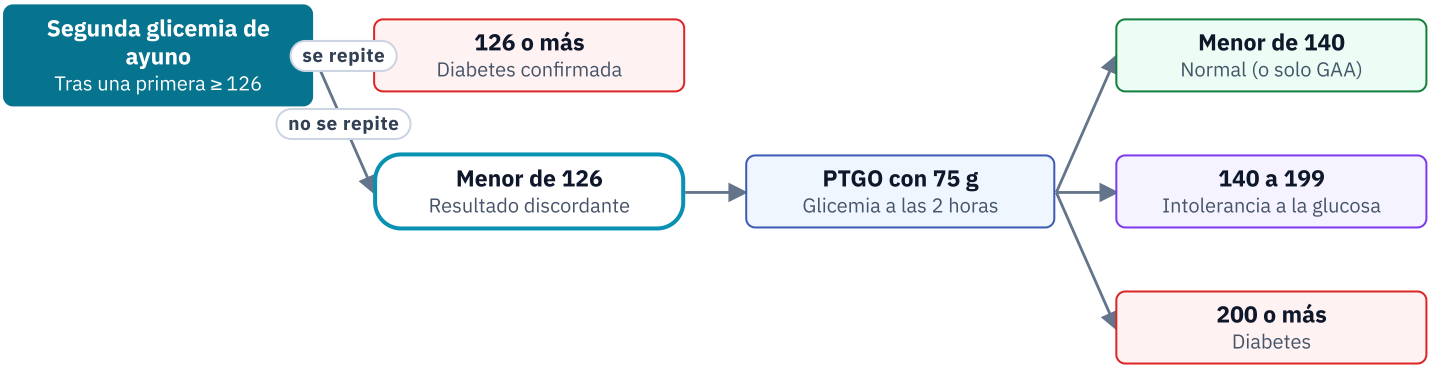


TABLA 1.2 · CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE HOMEOSTASIS GLUCÉMICA EN NO GESTANTES

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-02

CATEGORÍA	GLICEMIA DE AYUNO (8H)	PTGO 75G (A LAS 2 HORAS)	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)
Normal	< 100 mg/dL	< 140 mg/dL	< 5.7%
Glicemia de Ayuno Alterada (GAA)	100 a 125 mg/dL	< 140 mg/dL	5.7% a 6.4%
Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG)	< 100 o 100-125 mg/dL	140 a 199 mg/dL	5.7% a 6.4%
Diabetes Mellitus	≥ 126 mg/dL (confirmada)	≥ 200 mg/dL	≥ 6.5% (confirmada)
Crisis Hiperglicémica con Síntomas	Cualquier glicemia al azar ≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos (No requiere repetición)	—	—

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-02

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Síntomas + glicemia al azar ≥ 200	Diagnóstico confirmado: tratar	Pedir glicemia de ayuno para confirmar
Asintomático, ayuno ≥ 126	Repetir en otro día	Diagnosticar con un solo valor
Ayuno 100–125	PTGO con 75 g	Repetir la glicemia de ayuno

REGLA DE ORO **Ayuno 126 · PTGO 200 · HbA1c 6,5 %** — O azar 200 con síntomas

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **13–16** (pág. 10) · solucionario págs. 22–23.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES TIER 3

1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto

1.02.1.002	Diabetes gestacional	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.02.1.003	Diabetes mellitus pregestacional	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
3.01.1.004	Diabetes y embarazo	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	1.02.4.024	Test de tolerancia a la glucosa	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **En el embarazo NO existe la prediabetes**: cualquier glicemia de ayuno **≥ 100 mg/dL** confirmada es Diabetes Gestacional.
- Dos glicemias de ayuno **≥ 100 mg/dL** en cualquier momento del embarazo hacen el diagnóstico de Diabetes Gestacional.
- Si en las primeras **12 semanas** presenta glicemia de ayuno **≥ 126 mg/dL** confirmada, es Diabetes Pregestacional.
- La Diabetes Pregestacional aumenta el riesgo de malformaciones congénitas; la Diabetes Gestacional causa macrosomía y distocia.
- La PTGO de **75 g** se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28; el corte a las **2 horas** es **≥ 140 mg/dL**.

ALGORITMO · DIABETES EN EL EMBARAZO: EL MOMENTO Y EL VALOR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

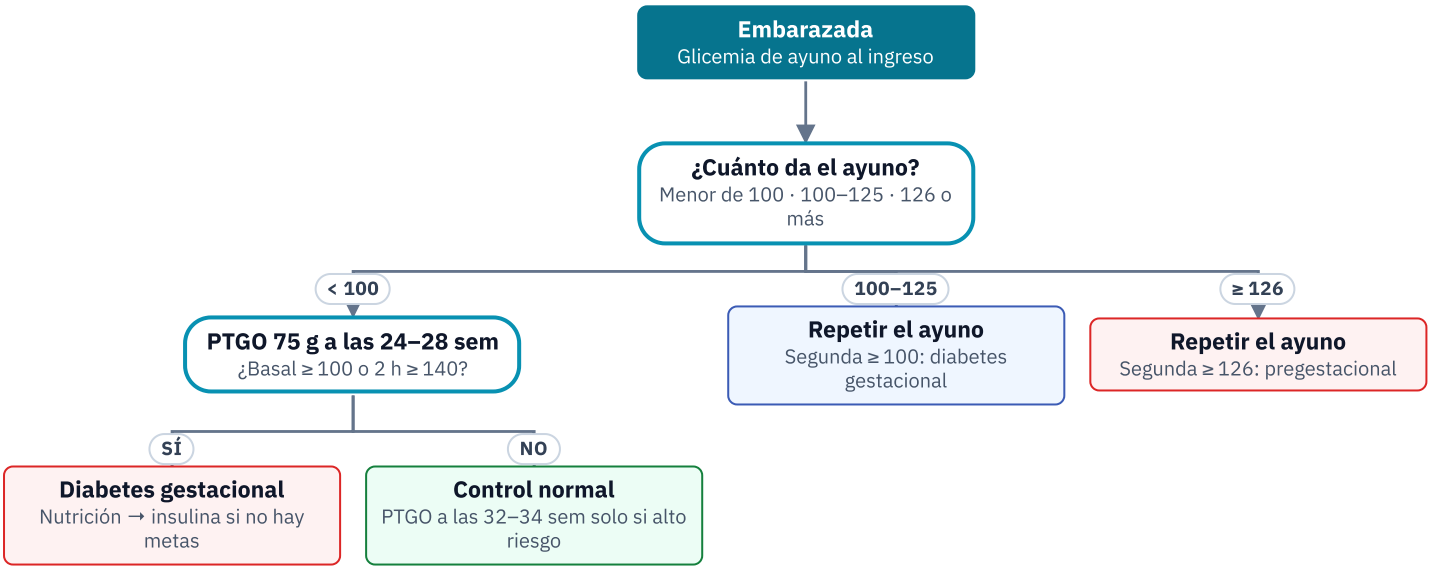


TABLA 1.3 · COMPARACIÓN CLÍNICA: DIABETES GESTACIONAL VS DIABETES PREGESTACIONAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-03

CARACTERÍSTICA	DIABETES GESTACIONAL (DMG)	DIABETES PREGESTACIONAL (DMPG)
Momento de inicio / pesquisa	Durante el embarazo (típicamente > 12 semanas)	Previa al embarazo o en primeras 12 semanas con glicemia ≥ 126
Riesgo de Malformaciones fetales	NO aumentado (organogénesis ya completada)	ALTO RIESGO (cardiopatías conotruncales, regresión caudal)
Complicaciones fetales típicas	Macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros	Malformaciones, RCIU por daño vascular, muerte in utero
Criterio diagnóstico en ayuno	≥ 100 mg/dL en 2 ocasiones	≥ 126 mg/dL en 2 ocasiones (o diagnóstico previo)
PTGO 75g a las 2 horas	≥ 140 mg/dL	≥ 200 mg/dL
Conducta postparto	PTGO con 75 g a las 6-12 semanas postparto	Mantener insulinoterapia según requerimiento crónico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-03

CARACTERÍSTICA	DIABETES GESTACIONAL	DIABETES PREGESTACIONAL
Después del parto	PTGO a las 6–12 semanas	Mantener su tratamiento

REGLA DE ORO **No existe la prediabetes** — Ayuno ≥ 100 · PTGO 2 h ≥ 140

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, pregunta **17** (pág. 10) · solucionario pág. 23.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

Alta · Metas individualizadas en adultos mayores vs jóvenes y costo de la hipoglicemia

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2

1.02.1.005 1.07.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
1.02.4.017	Hemoglobina glicosilada	Interpreta y emplea	
1.02.3.005	Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2**: < **7.0%** (glicemia preprandial **80–130 mg/dL**).
- El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< **6.0%**) en diabéticos con comorbilidad aumenta la mortalidad.
- En adultos mayores frágiles, con demencia o ERC avanzada, la meta se flexibiliza a HbA1c < **8.0%–8.5%**.
- Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo **8.0%** y no tiene síntomas de descompensación, NO se debe subir el tratamiento.
- La meta de presión arterial en diabetes es < 130/**80 mmHg** y el colesterol LDL debe ser < **70 mg/dL** (o < 55 en daño de órgano).

ALGORITMO · METAS DE HBA1C: ¿QUIÉN ES EL PACIENTE?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

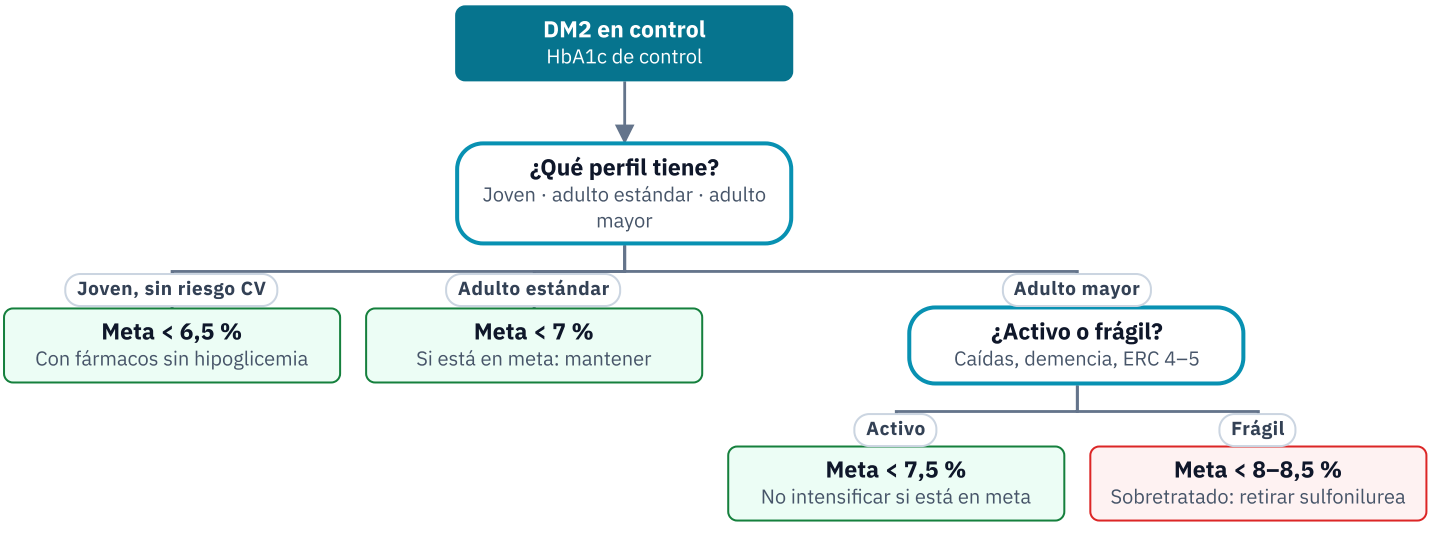


TABLA 1.4 · INDIVIDUALIZACIÓN DE METAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (ADA / MINSAL)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-04

PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE	META DE HBA1C	GLICEMIA PREPRANDIAL	GLICEMIA POSTPRANDIAL (2H)
Joven, diagnóstico reciente, sin complicaciones	< 6.5% - 7.0%	80 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Adulto estándar con DM2 y expectativa > 15 años	< 7.0%	80 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Adulto mayor activo, comorbilidad leve	< 7.5%	90 a 140 mg/dL	< 180-200 mg/dL
Adulto mayor frágil, demencia, ERC 4-5 o hipoglicemias	< 8.0% - 8.5%	100 a 150 mg/dL	< 200 mg/dL
Mujer embarazada con Diabetes Gestacional	< 6.0% (sin hipoglicemia)	< 90-95 mg/dL	< 120 mg/dL

REGLA DE ORO **Estándar < 7 % · joven < 6,5 %** — Estricto solo sin riesgo de hipoglicemia

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 23.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2

1.02.3.004	Estilos de vida saludables (hábitos y conductas)	Conocimiento general
1.02.3.003	Diabetes y riesgo cardiovascular	Conocimiento general
1.02.2.006	Hipoglicemias	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
7.01.3.032	Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares)	Conocimiento general
1.01.3.006	Sedentarismo vs actividad física	Conocimiento general
1.02.4.023	Test de esfuerzo	Emplea informe

LO QUE TE PREGUNTAN

- El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina.
- La recomendación universal es de al menos **150 minutos** semanales de ejercicio aeróbico moderado repartido en **≥ 3 días**.
- En usuarios de insulina o sulfonilureas, si la glicemia pre-ejercicio es < **100 mg/dL**, se debe consumir **15-20 g** de carbohidratos.
- El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por **24-48 horas**, pudiendo generar hipoglicemias nocturnas tardías.
- En pacientes con neuropatía diabética periférica se deben preferir actividades sin impacto (bicicleta, natación) e inspeccionar los pies.

ALGORITMO · EJERCICIO SEGURO EN EL PACIENTE CON DIABETES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

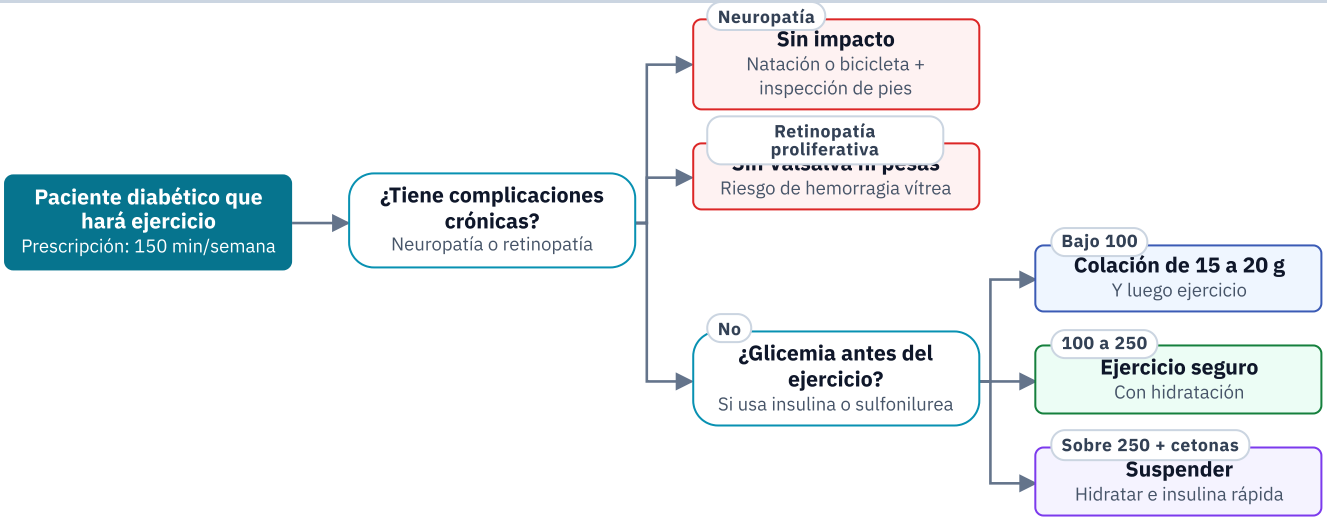


TABLA 1.5 · PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y RECOMENDACIONES GLUCÉMICAS EN DIABETES

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-05

SITUACIÓN CLÍNICA	NIVEL DE GLICEMIA PRE-ESFUERZO	CONDUCTA RECOMENDADA	FÁRMACOS DE ALTO RIESGO
Pre-ejercicio con hipoglicemia latente	< 100 mg/dL	Ingerir 15 a 20 g de hidratos de carbono antes de iniciar	Insulina NPH/Cristalina, Glibenclamida
Pre-ejercicio en rango seguro	100 a 250 mg/dL	Iniciar ejercicio aeróbico con hidratación adecuada	Cualquiera
Pre-ejercicio con hiperglicemia y cetonas	> 250 mg/dL con cetonuria (+)	Suspender ejercicio; hidratar y administrar insulina rápida	Diabetes Mellitus Tipo 1
Presencia de neuropatía sensitiva de pies	Indiferente	Evitar trote de impacto; preferir natación o bicicleta	Inspección de pies post-esfuerzo
Retinopatía proliferativa activa	Indiferente	Evitar pesas pesadas, saltos o maniobras de Valsalva	Riesgo de hemorragia vítrea

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-05

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Prescripción general	150 min/semana aeróbico moderado, ≥ 3 días	Dejar más de 2 días seguidos sin ejercicio

REGLA DE ORO **GLUT-4 sin insulina** — Sensibilidad aumentada 24 a 48 horas

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Diabetes Mellitus**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 1.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS TIER 3

2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

Máxima · Escalamiento de metformina a biterapia y criterios de inicio de insulina

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo	1.02.4.017	Hemoglobina glicosilada	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- La dosis terapéutica óptima de metformina es de **1.700 a 2.550 mg**/día (habitualmente **850 mg** c/**12h** o c/**8h**).
- Si a los **3 meses** de monoterapia la HbA1c es > **7.0%**, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- **Criterios de inicio inmediato de insulina**: HbA1c **≥ 9.0-10.0%**, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.
- En pacientes con insuficiencia cardíaca o nefropatía, los iSGLT2 son el segundo fármaco de elección indiscutido.

ALGORITMO · TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA DIABETES TIPO 2

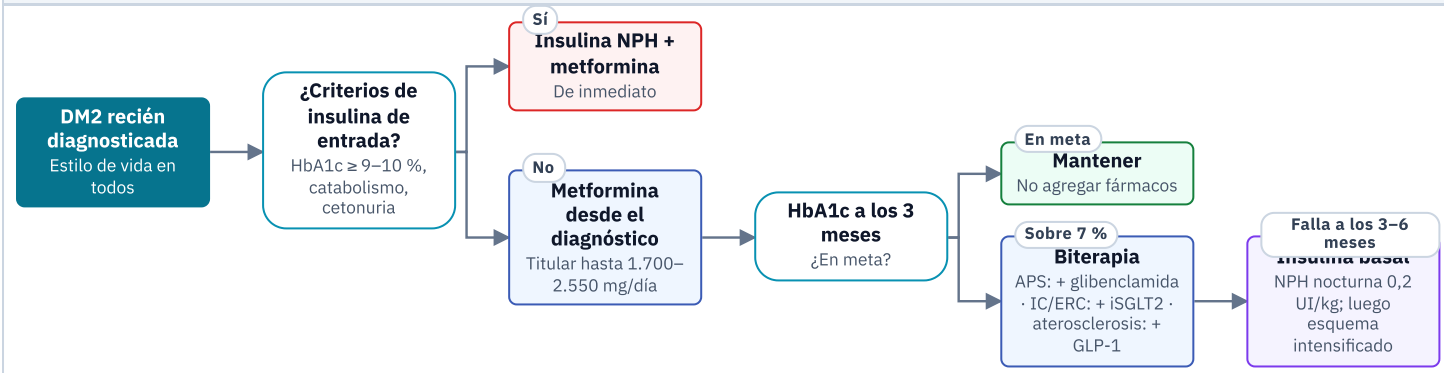


TABLA 2.1 · ESQUEMA DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN DIABETES TIPO 2 (GUÍAS MINSAL)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-06

NIVEL DE HBA1C	CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA	FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA	ALTERNATIVA / ESCALAMIENTO
HbA1c < 8.0%	Monoterapia oral + Estilo de vida	Metformina 850 mg c/12h con comidas	Reevaluar a los 3 meses; si > 7% sumar 2° fármaco
HbA1c 8.0% a 9.0%	Monoterapia máxima o Biterapia precoz	Metformina 1.700 a 2.550 mg/día	Asociar Glibenclamida 5 mg/d o iDPP4 / iSGLT2
HbA1c ≥ 9.0% asintomático	Biterapia oral directa obligatoria	Metformina + Segundo fármaco oral	Monitoreo en 30 a 60 días para evaluar respuesta
HbA1c ≥ 9.0% + Baja de peso / Síntomas	Insulinoterapia inmediata obligatoria	Insulina NPH nocturna (0.2-0.3 UI/kg) + Metformina	Ajuste semanal de insulina según glicemia matinal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-06

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
DM2 recién diagnosticada, sin síntomas	Estilo de vida + metformina desde el inicio	Meses de "prueba de dieta"
DM2 con IC o ERC	Agregar iSGLT2	Pioglitazona en la IC
Falla de biterapia a dosis máxima	Iniciar insulina basal	Subir más los orales
Plazos GES	Confirmar en 45 días; tratar en 24 h	Confundir los dos plazos

REGLA DE ORO **Metformina desde el diagnóstico** — Junto con el estilo de vida

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **19–23** (págs. 10–11) · solucionario págs. 23–24.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.2.006	Hipoglicemias	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.2.001	Acidosis láctica	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en monoterapia.
- La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < **30 mL**/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.
- Si la VFG está entre 30 y **44 mL**/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a **1.000 mg**/día.
- La glibenclamida es un secretagogo que estimula la liberación de insulina independiente de la glicemia plasmática.
- La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de hipoglicemias letales prolongadas.
- Toda hipoglicemia severa por glibenclamida exige hospitalización en observación con suero glucosado continuo por **24 horas**.

ALGORITMO · METFORMINA Y GLIBENCLAMIDA: SEGURIDAD

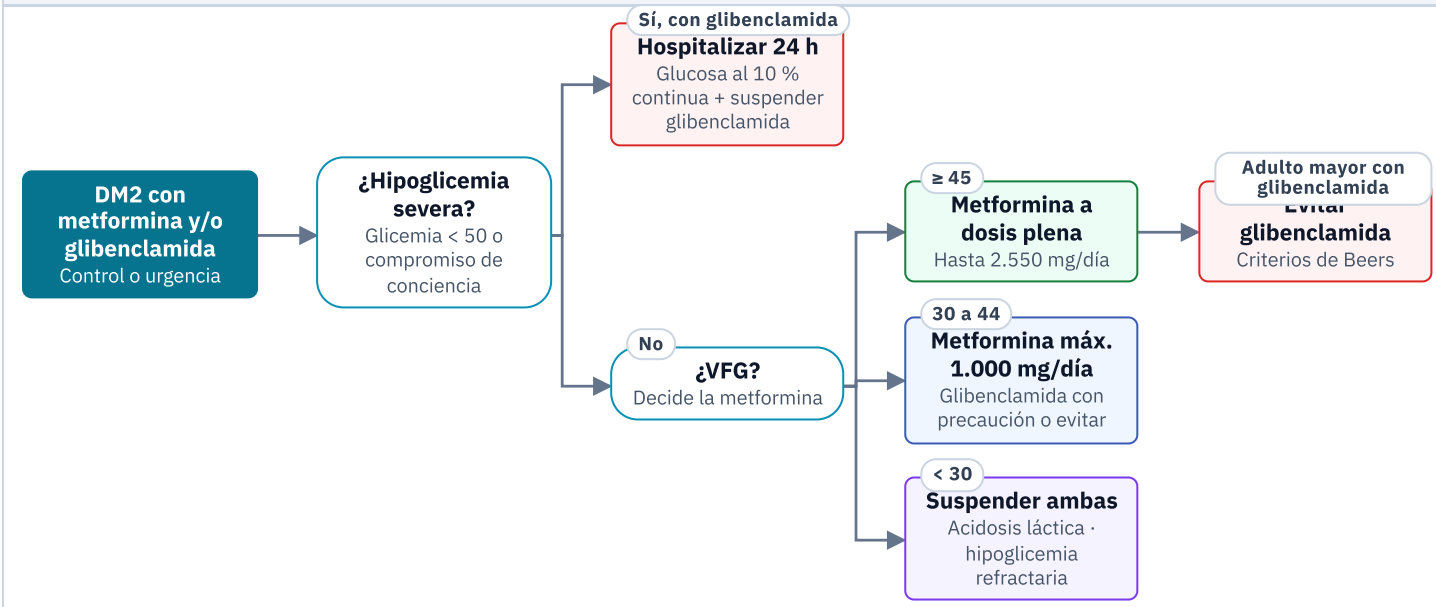


TABLA 2.2 · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA: METFORMINA VS GLIBENCLAMIDA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-07

PARÁMETRO	METFORMINA (BIGUANIDA)	GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA)
Mecanismo de acción	Inhibe gluconeogénesis hepática (vía AMPK)	Secretagogo: cierra canales K-ATP en célula beta
Riesgo de hipoglicemia	NULO en monoterapia	ALTO RIESGO (prolongada y grave)
Efecto sobre el peso	Neutro o modesta baja de peso (1-2 kg)	Aumento de peso (2 a 4 kg)
Ajuste renal (VFG 30-44)	Reducir dosis a máximo 1.000 mg/día	Usar con precaución o evitar
Ajuste renal (VFG < 30)	CONTRAINDICADA (Acidosis láctica)	CONTRAINDICADA (Hipoglicemia refractaria)
Uso en Adulto Mayor	De elección si la función renal es segura	DESACONSEJADA / EVITAR (Criterios Beers)
Efecto secundario cardinal	Gastrointestinal (diarrea, náuseas, meteorismo)	Hipoglicemia sintomática grave

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-07

PARÁMETRO	METFORMINA	GLIBENCLAMIDA
Usuario de metformina con falla renal aguda o sepsis, vómitos y Kussmaul	Lactato alto, cetonas negativas: suspender y derivar	Tratarla como cetoacidosis

REGLA DE ORO **Frena al hígado, sin hipoglicemia** — Vía AMPK

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **24–25** (pág. 11) · solucionario pág. 24.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

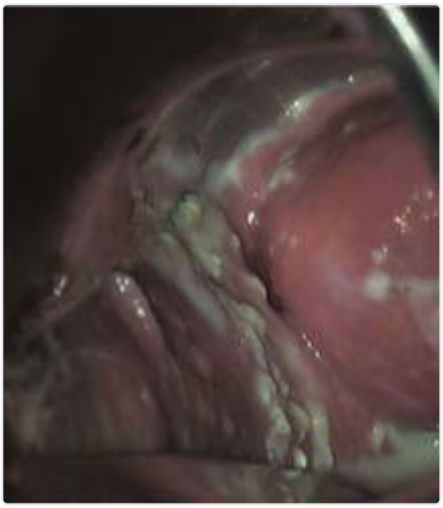
2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo	1.02.3.003	Diabetes y riesgo cardiovascular	Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora.
- Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión de la enfermedad renal crónica.
- El efecto adverso más común de los iSGLT2 son las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis).
- **Riesgo grave de iSGLT2**: Cetoacidosis Diabética Euglicémica ante situaciones de estrés quirúrgico o ayuno prolongado.
- Los agonistas de GLP-1 inducen marcada saciedad y baja de peso, reduciendo eventos ateroscleróticos mayores (IAM, ACV).
- La linagliptina (iDPP-4) tiene eliminación biliar y NO requiere ajuste de dosis en falla renal avanzada.



CANDIDIASIS VAGINAL
Kumar and Clark, Clinical Medicine, p. 1587

ALGORITMO · SEGUNDO FÁRMACO SEGÚN EL ÓRGANO DIANA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

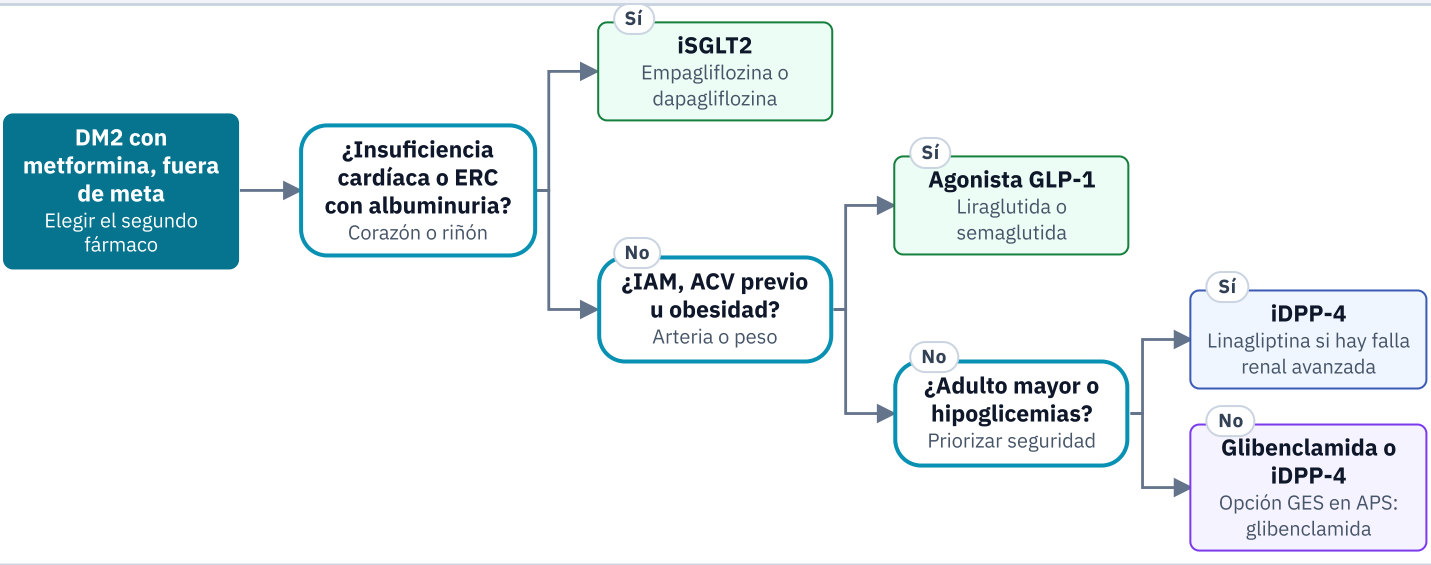


TABLA 2.3 · CUADRO COMPARATIVO: ISGLT2 VS AGONISTAS GLP-1 VS IDPP-4

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-08

FAMILIA	MECANISMO PRIMARIO	IMPACTO EN PESO	BENEFICIO ÓRGANO BLANCO	EFECTO ADVERSO SELLO
iSGLT2 (Gliflozinas)	Glucosuria tubular proximal	Baja 2 a 3 kg	Insuficiencia cardíaca y Nefroprotección	Micosis genitales y CAD euglicémica
GLP-1 RA (Incretinas)	Receptor GLP-1 (saciedad/incretina)	Baja 5 a 15 kg	Enfermedad coronaria aterosclerótica y ACV	Náuseas y vómitos al titular
iDPP-4 (Gliptinas)	Inhibe degradación de GLP-1	Neutro	Seguridad global; sin hipoglicemias	Raro: pancreatitis aguda

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-08

FAMILIA	BENEFICIO QUE SE PREGUNTA	EFECTO ADVERSO SELLO	PESO
Linagliptina	Sin ajuste en ninguna falla renal	Eliminación biliar	Neutro

REGLA DE ORO **IC y ERC con albuminuria** — Glucosuria, sin hipoglicemia

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **26–27** (págs. 11–12) · solucionario pág. 24.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

Alta · Criterios estrictos de inicio de insulina y contraindicación de sulfonilureas

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto

1.02.1.002	Diabetes gestacional	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.02.1.003	Diabetes mellitus pregestacional	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
3.01.1.004	Diabetes y embarazo	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.02.4.015	Glicemia capilar	Realiza, interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

- El **70-80%** de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada.
- El periodo de prueba de la dieta es de **1 a 2 semanas** con automonitoreo de 4 a 6 controles capilares al día.
- Si más del **20%** de los controles superan las metas (ayuno > 90-95 o **1h** post > 140), se debe iniciar insulina.
- La circunferencia abdominal fetal ≥ percentil 75-90 en ecografía es indicación de iniciar insulina precozmente.
- La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.
- La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar hipoglicemia neonatal severa.

ALGORITMO · DIABETES GESTACIONAL: DE LA DIETA A LA INSULINA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

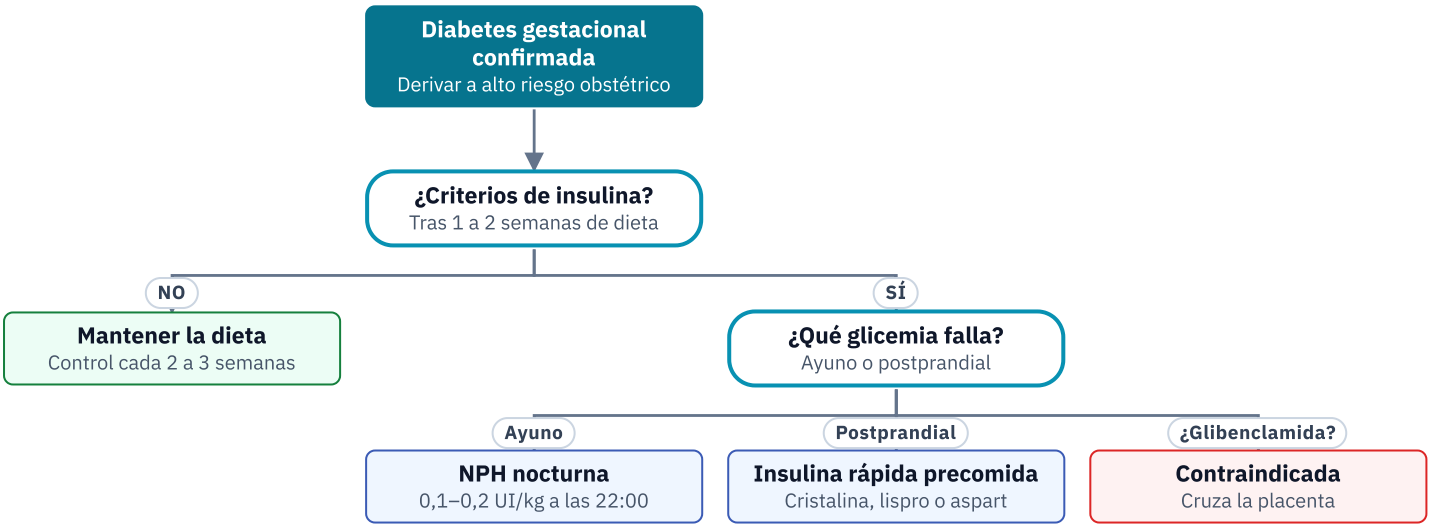


TABLA 2.4 · MONITOREO Y METAS TERAPÉUTICAS EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-09

MOMENTO DE MEDICIÓN	META GLUCÉMICA CAPILAR	FÁRMACO DE RESCATE SI FALLA	OBSERVACIÓN CLÍNICA
Glicemia en ayunas (pre-desayuno)	70 a 90 - 95 mg/dL	Insulina NPH a las 22:00 h	Evalúa secreción basal nocturna materna
Glicemia 1 hora postprandial	< 140 mg/dL	Insulina Cristalina o Lispro precomida	Peak de glucosa en el embarazo
Glicemia 2 horas postprandial	< 120 mg/dL	Insulina Cristalina precomida	Alternativa si no se mide a la hora
Glicemia nocturna (03:00 AM)	> 60 mg/dL	Disminuir NPH o sumar colación	Descartar hipoglicemias nocturnas inadvertidas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-09

MOMENTO	META	SI FALLA
Falla de la dieta	Insulina	Glibenclamida: prohibida

REGLA DE ORO **Controla al 70–80 %** — Fraccionada, nunca bajo 1.500 kcal

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **28–29** (pág. 12) · solucionario pág. 25.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

GES — Garantía Explícita en Salud (GES): Hipertensión Arterial Primaria y DM2

1.02.1.008	Hipertensión arterial en diabetes tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.010	Nefropatía incipiente	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/**80 mmHg**.
- En diabéticos con albuminuria (RAC **≥ 30 mg/g**), los fármacos de primera línea obligatorios son IECA o ARA-II.
- **Mecanismo nefroprotector**: vasodilatación selectiva de la arteriola eferente que reduce la presión intraglomerular.
- Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia.
- Si la PA basal es **≥ 140/90 mmHg** se recomienda iniciar biterapia asociando IECA/ARA-II con Amlodipino.
- Los betabloqueadores no son de primera línea en HTA pura en DM salvo indicación cardiológica (IAM o IC).

ALGORITMO · HIPERTENSIÓN EN EL DIABÉTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

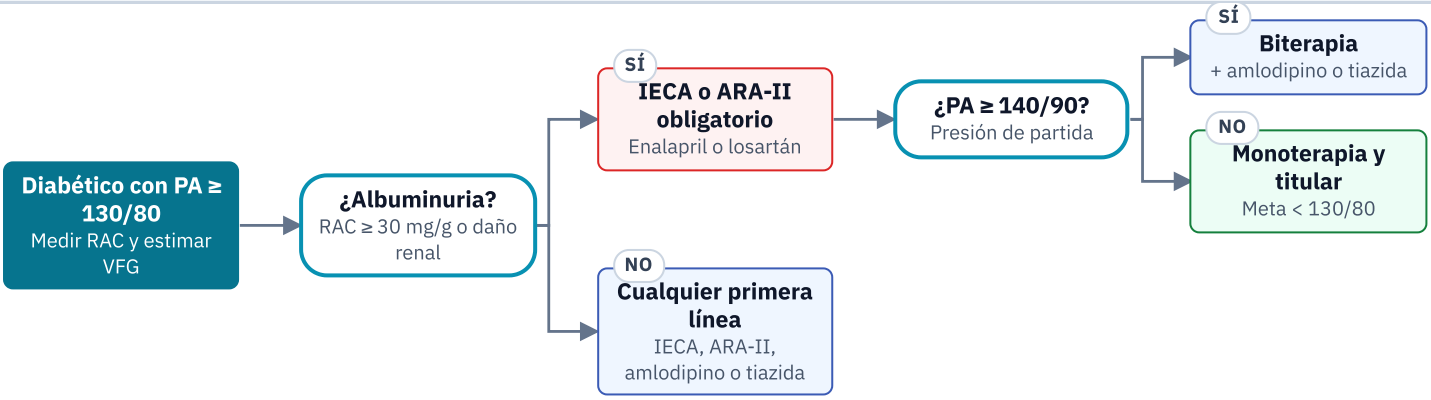


TABLA 2.5 · ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN EL PACIENTE DIABÉTICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-10

CONDICIÓN RENAL	FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA	FÁRMACO PARA BITERAPIA	META TENSIONAL
Diabético con Albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g)	IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán)	Calcioantagonista (Amlodipino)	< 130/80 mmHg
Diabético sin Albuminuria (RAC < 30 mg/g)	Cualquiera: IECA, ARA-II, Amlodipino o Tiazida	Combinación de dos clases principales	< 130/80 mmHg
Diabético con Cardiopatía Coronaria previa	IECA/ARA-II + Betabloqueador cardioselectivo (Atenolol/Bisoprolol)	Amlodipino	< 130/80 mmHg
Diabético con VFG < 30 mL/min	IECA/ARA-II con monitoreo estricto de Potasio	Diurético de asa (Furosemida) o Amlodipino	< 130/80 mmHg

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-10

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
PA ≥ 140/90 al inicio	Biterapia: IECA o ARA-II + amlodipino	Monoterapia y esperar
Proteinuria que persiste	Optimizar un solo bloqueador	Sumar IECA + ARA-II
Ya usa tiazida y atenolol, con proteinuria	Agregar IECA	Mantener o cambiar el diurético

REGLA DE ORO — **PA < 130/80 mmHg** — Biterapia si parte ≥ 140/90

PRACTICA — **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **30–36** (págs. 12–13) · solucionario págs. 25–26.

Clase 2.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

GES — Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.004	Diabetes Mellitus tipo 1	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La insulina NPH tiene un pico a las **4–10 horas**; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:**00 hrs**).
- Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en **10-15 minutos** y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere **30 minutos** de anticipación.
- La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).
- La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.
- En DM2 con HbA1c **≥ 9.0–10.0%** y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.
- En insuficiencia renal avanzada (VFG < **30 ml**/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.



LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL
Open-i (NLM), CC BY

ALGORITMO · DM2: ¿CUÁNDO SE INICIA INSULINA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

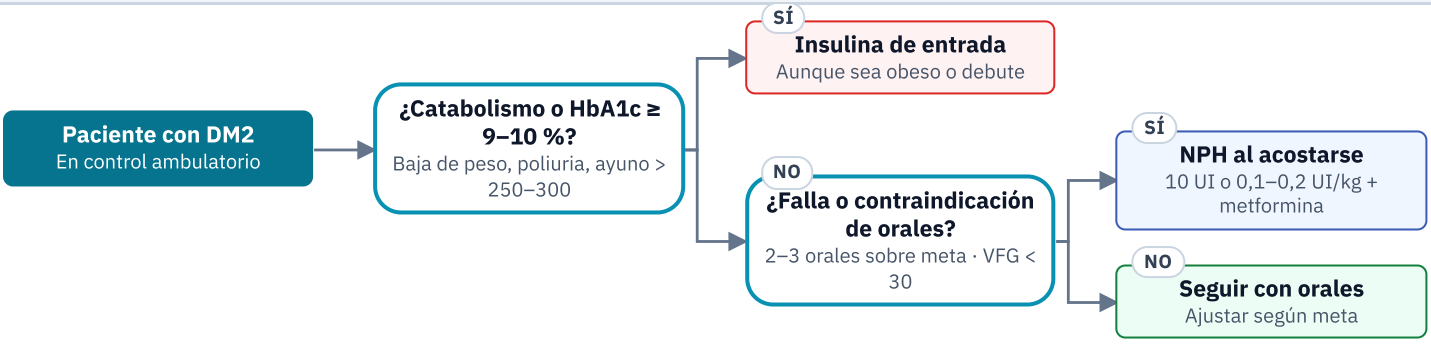


TABLA 3.1 · COMPARACIÓN FARMACOCINÉTICA DE LAS PRINCIPALES FORMULACIONES DE INSULINA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-11

TIPO DE INSULINA	FÁRMACOS REPRESENTATIVOS	INICIO DE ACCIÓN	PICO MÁXIMO	DURACIÓN EFECTIVA	MOMENTO DE INYECCIÓN
Ultrarrápida (Análogo)	Aspart, Lispro, Glulisina	10 – 15 minutos	1 – 2 horas	3 – 5 horas	0 a 15 min antes de comer (o justo después)
Rápida (Humana regular)	Cristalina / Regular	30 – 60 minutos	2 – 3 horas	6 – 8 horas	30 minutos antes de la comida principal
Intermedia (Humana NPH)	NPH (Isófana)	1 – 2 horas	4 – 10 horas (marcado)	12 – 18 horas	Al acostarse (bedtime, 22-23h) o c/12h
Prolongada (Análogo)	Glargina U100, Detemir	1 – 2 horas	Sin pico (plano)	20 – 24 horas	1 vez al día, a la misma hora
Ultraprolongada (Análogo)	Degludec, Glargina U300	30 – 90 minutos	Sin pico (ultraplano)	> 24 a 42 horas	1 vez al día (mayor flexibilidad horaria)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-11

INSULINA	INICIO · PEAK · DURACIÓN	CUÁNDO SE INYECTA
Cristalina (regular)	30–60 min · 2–3 h · 6–8 h	30 min antes de comer; también EV

REGLA DE ORO — **NPH: peak 4–10 h** — Siempre al acostarse

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **37–39** (pág. 13) · solucionario pág. 26.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO TIER 3

3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

Máxima · Ajuste de insulina NPH, corrección postprandial, fenómeno del alba y efecto Somogyi

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.004	Diabetes Mellitus tipo 1	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.2.006	Hipoglicemias	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.4.015	Glicemia capilar	Realiza, interpreta y emplea		

LO QUE TE PREGUNTAN

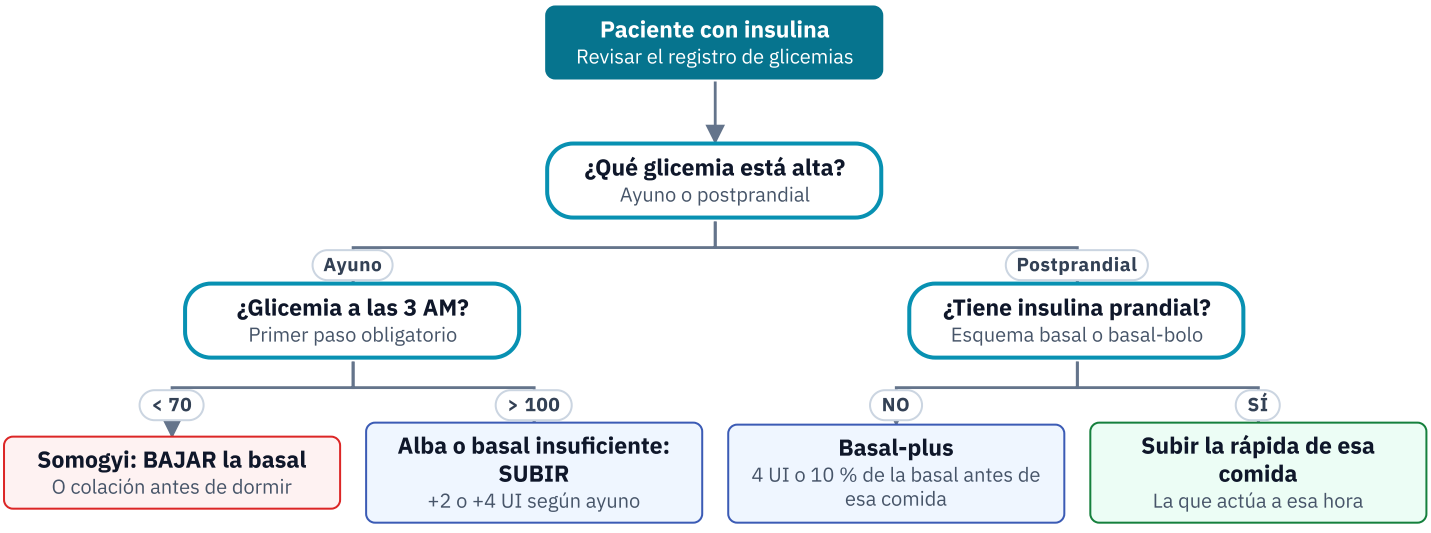
- **La regla de oro del ajuste prandial**: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de insulina rápida previa a ESA comida específica.
- Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.
- **Si a las 03**:00 AM la glicemia es < **70 mg/dL**, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > **100 mg/dL**, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.
- El esquema basal bedtime consiste en NPH **10 UI** o **0.1-0.2 UI**/kg a las 22:00-23:**00 hrs** manteniendo metformina oral.
- Los ajustes de insulina basal ambulatoria se realizan cada **3 a 7 días** en escalones de +**2 UI** (si **130-180 mg/dL**) o +**4 UI** (si > **180 mg/dL**).
- Si el paciente presenta hipoglicemia en cualquier momento, la dosis responsable debe reducirse inmediatamente en un **10-20%** (**2 a 4 UI**).
- Si la glicemia de ayuno está en meta (< **130 mg/dL**) pero la HbA1c sigue > **7.0%**, se debe iniciar esquema Basal-Plus cubriendo la comida con mayor excursión glucémica.



LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL
Open-i (NLM), CC BY

ALGORITMO · AJUSTE DE INSULINA: QUÉ GLICEMIA FALLA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **40–43** (págs. 13–14) · solucionario págs. 26–27.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 3.2 · COMPARACIÓN ENTRE ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA EN DIABETES MELLITUS

ESQUEMA	COMPONENTES	POBLACIÓN OBJETIVO	MONITOREO REQUERIDO	RIESGO HIPOGLICEMIA
Basal Bedtime	NPH 10 UI o Glargina al acostarse + Metformina oral	DM2 que no responde a terapia oral combinada	Glicemia capilar matinal en ayunas	Bajo a moderado
Basal-Plus	Basal nocturna + 1 bolo prandial (almuerzo o comida principal)	DM2 con ayuno en meta pero HbA1c > 7.0%	Ayuno + postprandial de la comida intervenida	Moderado
Basal-Bolo Intensificado	1-2 basales (NPH c/12h o Glargina) + 3 bolos prandiales	Todos los DM1 y DM2 con déficit insulínico severo	Monitoreo 4-6 veces/día (pre y postcomidas)	Alto (requiere educación estricta)
Bifásico (Mezclas fijas)	Premezcla NPH/Cristalina (70/30) 2 veces/día con desayuno y cena	DM2 con horarios de comida muy regulares y baja adherencia a múltiples punciones	Pre-desayuno y pre-cena	Moderado-alto (poca flexibilidad horaria)

TRAMPAS EUNACOM clase diab-12

CUADRO	GLICEMIA 3 AM	CONDUCTA	ERROR TÍPICO
Efecto Somogyi	< 70 mg/dL	BAJAR la basal o colación nocturna	Subir la insulina nocturna
Fenómeno del alba	> 100 mg/dL	SUBIR la basal o retrasarla al acostarse	Bajar la insulina nocturna
Basal insuficiente	> 140 mg/dL	Subir la basal o fraccionar la NPH	Agregar rápida nocturna
Hiperglicemia post-almuerzo	Normal	Subir la rápida del almuerzo	Subir la NPH

REGLA DE ORO **NPH bedtime + metformina** — Titular con el ayuno cada 3 a 7 días

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El ajuste fino de la insulinoterapia es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. Un error clásico de los médicos recién egresados es aumentar la insulina nocturna ante una hiperglicemia matinal sin haber descartado previamente una hipoglicemia a las 03:00 AM (Efecto Somogyi). Comprender la lógica de la titulación ambulatoria, el esquema basal-plus y basal-bolo, y la regla de ajuste de la insulina prandial según el automonitoreo permite responder con precisión casos clínicos complejos.

TABLA 3.2.B · ALGORITMO DE TITULACIÓN ESCALONADA DE INSULINA NPH AMBULATORIA

NIVEL DE GLICEMIA EN AYUNO	AJUSTE DE DOSIS BASAL	FRECUENCIA DE CONTROL	OBJETIVO CLÍNICO
< 70 mg/dL (Hipoglicemia)	Reducir 2 a 4 UI (o 10-20% de la dosis)	Inmediato (control al día siguiente)	Evitar hipoglicemia grave y neuroglucopenia
70 – 130 mg/dL (En Meta)	Mantener dosis sin cambios	Cada 3 meses con HbA1c	Consolidar control glucémico basal
131 – 180 mg/dL (Levemente alta)	Aumentar 2 UI de NPH al acostarse	Reevaluar en 3 a 7 días con 3 ayunos	Llevar progresivamente a meta < 130 mg/dL
> 180 mg/dL (Francamente alta)	Aumentar 4 UI de NPH al acostarse	Reevaluar en 3 a 5 días	Superar rápidamente la glucotoxicidad
Postprandial > 180 mg/dL con ayuno en meta	Agregar 4 UI de insulina rápida antes de esa comida	Reevaluar glicemia a las 2h postprandial	Tránsito a esquema Basal-Plus

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **40–43** (págs. 13–14) · solucionario págs. 26–27.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

★★★ PRIORIDAD ALTA
24 preguntas reales 2013–2025

GES — Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.006	Diabetes por corticoides	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.4.015	Glicemia capilar	Realiza, interpreta y emplea		

LO QUE TE PREGUNTAN

- La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente **140 – 180 mg/dL** (7.8 – 10.0 mmol/L).
- Metas estrictas (< **110 mg/dL**) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia severa (evidencia del ensayo NICE-SUGAR).
- La metformina DEBE suspenderse siempre ante sepsis, shock, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o uso de contraste yodado por riesgo de acidosis láctica.
- Las sulfonilureas deben suspenderse al ingresar al hospital por el riesgo extremo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta errática.
- El uso exclusivo del esquema móvil de insulina rápida (sliding scale) está proscrito por ineficaz y riesgoso; debe usarse un esquema basal-corrección.

ALGORITMO · HIPERGLICEMIA EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

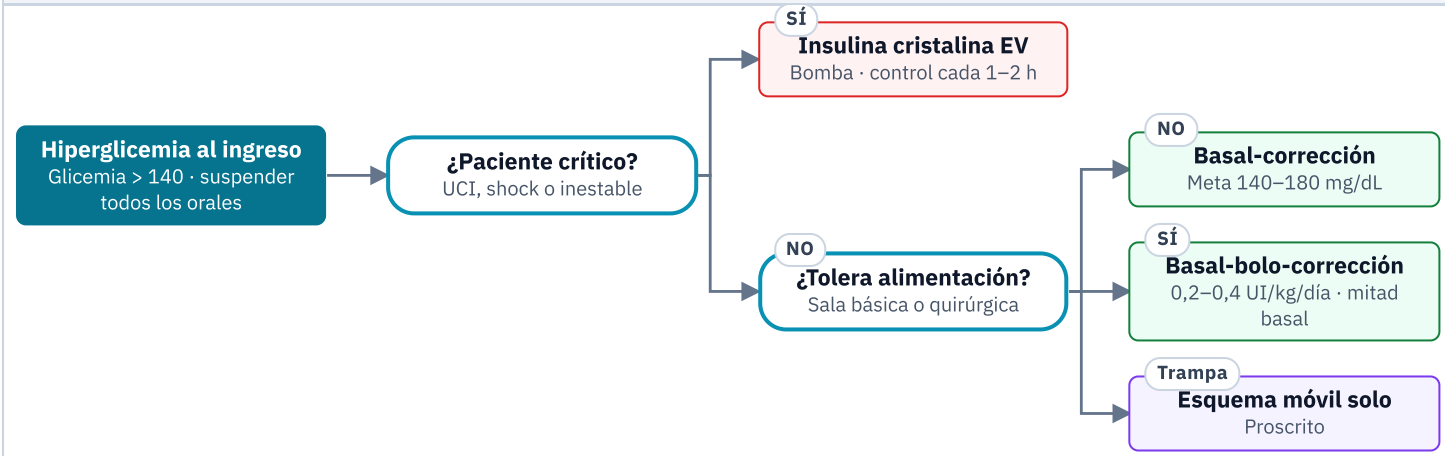


TABLA 3.3 · MANEJO DE FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-13

FÁRMACO / ESQUEMA	CONDUCTA AL INGRESO	RIESGO PRINCIPAL	ESTRATEGIA DE REEMPLAZO
Metformina	SUSPENDER sistemáticamente	Acidosis láctica ante sepsis, hipoxemia o contraste	Insulina basal + bolos de corrección
Sulfonilureas (Glibenclamida)	SUSPENDER sistemáticamente	Hipoglicemia severa y prolongada (inapetencia / ayuno)	Insulina basal + bolos de corrección
iSGLT2 (Dapagliflozina, etc.)	SUSPENDER sistemáticamente	Cetoacidosis diabética euglicémica y deshidratación	Insulina subcutánea programada
Esquema Móvil Aislado ("Sliding scale")	PROSCRIBIR como terapia única	Ineficacia, hiperglicemia de rebote e hipoglicemia	Esquema Basal-Bolo o Basal-Corrección
Insulina Cristalina EV en Bomba	De elección en UCI y paciente crítico	Hipoglicemia si no hay control horario	Control de hemoglucotest c/1-2 horas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-13

FÁRMACO O ESQUEMA	CONDUCTA	POR QUÉ
Meta en todo hospitalizado	140–180 mg/dL	< 110 aumenta la mortalidad
Prednisona matinal, ayuno normal, glicemias de 250 en la tarde	NPH matinal junto con la prednisona	Basal nocturna guiada por el ayuno

REGLA DE ORO — **140 a 180 mg/dL** — Menos de 110 aumenta la mortalidad

PRACTICA — **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **44–45** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO TIER 3

3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica APS

1.02.2.006	Hipoglicemias	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
1.02.4.018	Insulinemia	Interpreta y emplea	
1.02.4.015	Glicemia capilar	Realiza, interpreta y emplea	
2.01.2.004	Compromiso de conciencia	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La Tríada de Whipple exige**: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir glucosa.
- **La Regla de los 15 (para pacientes conscientes)**: 15 gramos de carbohidratos simples por boca, esperar **15 minutos** y repetir glicemia.
- En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica Glucosa al **30%** EV (**20-50 ml**) o Glucagón **1 mg** IM/SC.
- ¡REGLA ABSOLUTA DE EUNACOM! Todo paciente con hipoglicemia por sulfonilureas (glibenclamida) DEBE hospitalizarse por **24 a 48 horas** con infusión de suero glucosado.
- Los betabloqueadores no cardioselectivos (propranolol) bloquean la taquicardia, palpitaciones y temblor de la hipoglicemia, pero NO la sudoración.

ALGORITMO · HIPOGLICEMIA: RESCATE Y DESTINO

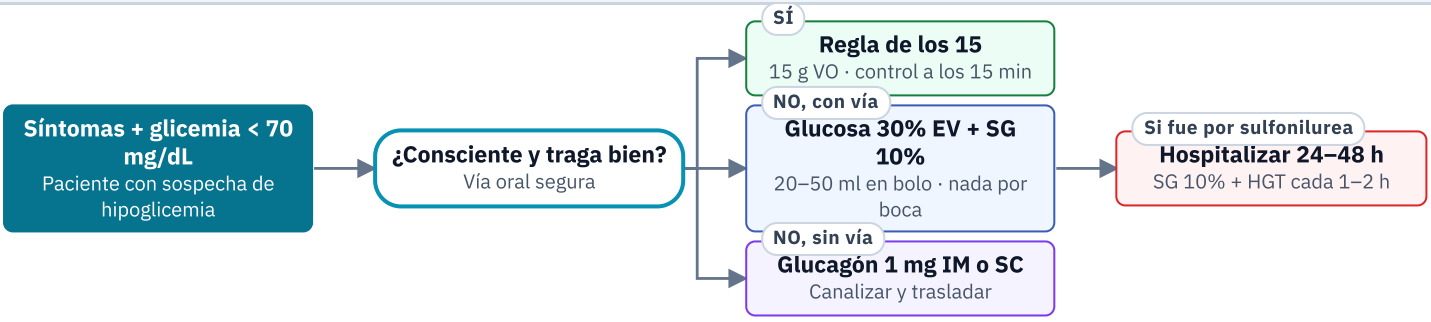


TABLA 3.4 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA HIPOGLICEMIA SEGÚN ADA Y MINSAL

NIVEL DE SEVERIDAD	VALOR BIOQUÍMICO	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PRIMARIA
Nivel 1 (Alerta)	Glicemia < 70 mg/dL y ≥ 54 mg/dL	Síntomas adrenérgicos leves (sudoración, temblor, hambre)	Regla de los 15 por vía oral (15 g de hidratos de carbono simples)
Nivel 2 (Significativa)	Glicemia < 54 mg/dL (< 3.0 mmol/L)	Síntomas neuroglucopénicos incipientes (confusión, cefalea)	Carbohidratos orales rápidos inmediatos + colación compleja
Nivel 3 (Severa)	Sin umbral numérico fijo	Compromiso de conciencia, convulsión, incapacidad de autotratamiento	Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC

TRAMPAS EUNACOM

clase diab-14

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Consciente, traga bien	Regla de los 15	Glucagón o vía venosa de entrada
Inconsciente, con vía venosa	Glucosa 30% EV 20–50 ml + SG 10%	Dar jugo o azúcar por boca
Inconsciente, sin vía, en domicilio	Glucagón 1 mg IM o SC	Esperar la ambulancia sin tratar

REGLA DE ORO **Síntomas + glicemia baja + alivio** — Nivel 3 se define por la clínica

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **46–54** (págs. 14–15) · solucionario págs. 27–28.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS TIER 3

4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria

1.02.2.002	Cetoacidosis	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar
1.02.2.003	Coma hiperosmolar	Dx Específico	Tx Inicial	Seg No requiere
1.02.4.006	Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo)	Realiza, interpreta y emplea		
1.02.2.007	Síndrome hiperosmolar no cetósico	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.4.007	Cuerpos cetónicos en sangre	Interpreta y emplea		

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La CAD se define por la tríada**: Glicemia > **250 mg/dL** + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > **10–12 mEq/L** con cetonemia positiva.
- **El EHH se define por**: Glicemia > **600 mg/dL** + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > **18 mEq/L** sin cetosis.
- **La osmolaridad efectiva se calcula**: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- **El sodio medido debe corregirse siempre**: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100).

ALGORITMO · DIABÉTICO DESCOMPENSADO: CAD O EHH

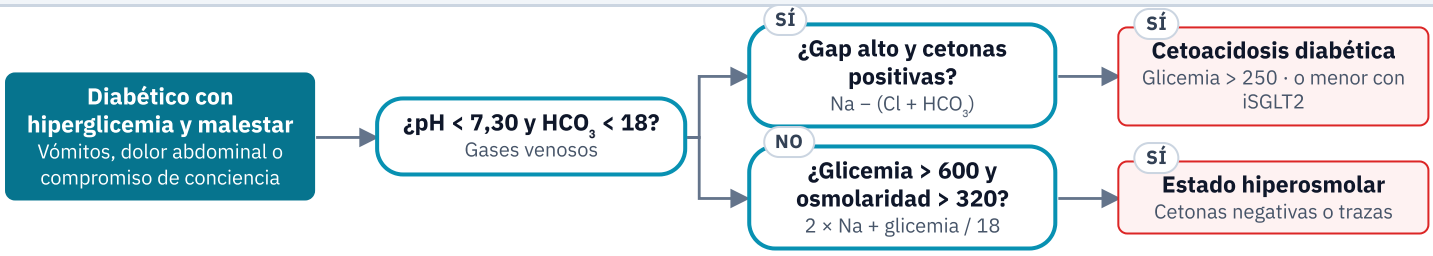


TABLA 4.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO Y CLÍNICO: CAD VS EHH

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-15

PARÁMETRO	CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)	ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH)
Población Típica	DM1 niños o jóvenes (debut 25-30% o abandono insulina)	DM2 adultos mayores o ancianos institucionalizados
Tiempo de Instalación	Agudo y rápido (< 24 a 48 horas)	Insidioso y progresivo (días a semanas)
Nivel de Glicemia	250 a 600 mg/dL (o < 250 mg/dL en euglicémica por iSGLT2)	Típicamente > 600 a 1200 mg/dL
pH Arterial / Venoso	< 7.30 (moderada < 7.24, severa < 7.00)	> 7.30 (habitualmente > 7.35)
Bicarbonato Sérico	< 18 mEq/L (severa < 10 mEq/L)	> 18 mEq/L (normal o levemente disminuido)
Anion Gap	ELEVADO (> 10 a 12 mEq/L)	Normal (< 12 mEq/L)
Cetonemia / Cetonuria	POSITIVA intensa (beta-hidroxibutirato > 3 mmol/L)	Negativa o trazas mínimas
Osmolaridad Efectiva	Variable, habitualmente < 320 mOsm/kg	MARCADAMENTE ELEVADA (> 320 mOsm/kg)
Déficit de Volumen	Moderado (3 a 6 litros, ~10% peso corporal)	Severo y extremo (8 a 12 litros, ~15-20% peso)
Clínica Cardinal	Dolor abdominal (abdomen agudo médico), vómitos, Kussmaul	Sopor, estupor, coma, signos focales neurológicos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-15

PARÁMETRO	CETOACIDOSIS	ESTADO HIPEROSMOLAR
Paciente e instalación	Joven DM1 · < 24–48 h	Adulto mayor DM2 · días a semanas
Seguimiento de la cetoacidosis ya en tratamiento	Anión gap, bicarbonato y beta-hidroxibutirato	Guiarse por la tira de cetonuria

REGLA DE ORO **> 250 + pH < 7,30 + gap alto** — Con cetonas positivas

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **56–64** (págs. 16–17) · solucionario págs. 29–30.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS TIER 3

4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

Máxima · Primera medida de manejo, cálculo de sodio corregido, uso de suero fisiológico vs hipotónico y momento del suero glucosado

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica Hospitalaria

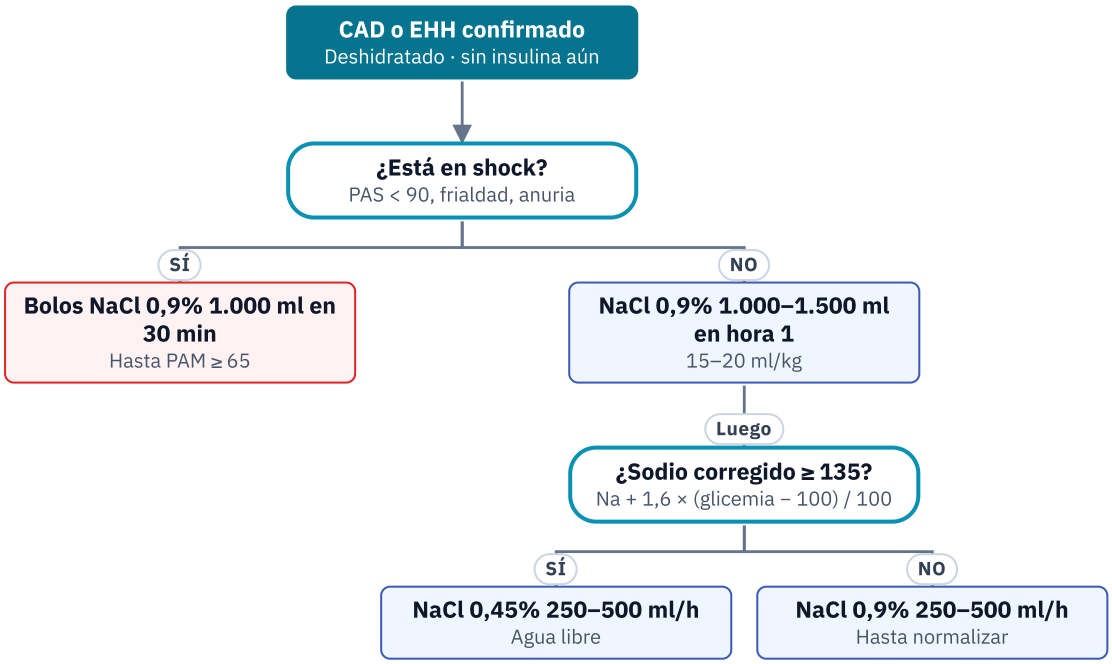
1.02.2.002	Cetoacidosis	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar	1.02.2.007	Síndrome hiperosmolar no cetósico	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.02.2.003	Coma hiperosmolar	Dx Específico · Tx Inicial · Seg No requiere	2.01.1.073	Diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl **0.9% 1.000 a 1.500 ml** en la primera hora).
- Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.
- **Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido**: si es **≥ 135 mEq/L** se cambia a solución salina hipotónica al **0.45%**; si es < **135 mEq/L** se continúa con NaCl **0.9%**.
- **Regla mandataria**: cuando la glicemia sea **≤ 200 mg/dL** en CAD o **≤ 300 mg/dL** en EHH, se DEBE agregar Suero Glucosado al **5%** a la hidratación.
- La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a **200 mg/dL** si el Anion Gap sigue abierto; se reduce su dosis y se infunde glucosa parenteral.
- El déficit hídrico medio es de 3 a 6 litros en CAD y de 8 a 12 litros en EHH; su reposición debe completarse en **24 a 48 horas**.
- El descenso glicémico seguro es de **50 a 75 mg/dL** por hora; descensos más rápidos (> **100 mg/dL**/h) predisponen a edema cerebral.

ALGORITMO · FLUIDOTERAPIA EN CAD Y EHH

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **65–68** (pág. 17) · solucionario págs. 30–31.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 4.2 · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE FLUIDOTERAPIA EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS (CAD Y EHH) = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-16

FASE DEL TRATAMIENTO	TIEMPO / PARÁMETRO CLAVE	SOLUCIÓN INTRAVENOSA	VELOCIDAD DE INFUSIÓN	OBJETIVO CLÍNICO
Fase 1: Expansión Inicial	Hora 1 (todos los pacientes)	NaCl 0.9% (Suero Fisiológico)	1.000 a 1.500 ml/h (15-20 ml/kg)	Restaurar volemia eficaz y perfusión renal
Fase 2A: Na Corregido Normal/Alto	Horas 2 a 24 (Na corr ≥ 135)	NaCl 0.45% (Solución Hipotónica)	250 a 500 ml/h	Reponer déficit de agua libre intracelular
Fase 2B: Na Corregido Bajo	Horas 2 a 24 (Na corr < 135)	NaCl 0.9% (Suero Fisiológico)	250 a 500 ml/h	Corregir hiponatremia y sostener intravascular
Fase 3: Transición Glucídica (CAD)	Glicemia alcanza ≤ 200 mg/dL	Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45%	150 a 250 ml/h	Prevenir hipoglicemia y PERMITIR continuar insulina
Fase 3: Transición Glucídica (EHH)	Glicemia alcanza ≤ 300 mg/dL	Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45%	150 a 250 ml/h	Evitar caída brusca de osmolaridad y edema cerebral

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA clase diab-16

MOMENTO	SUERO	VELOCIDAD
Shock: PAS < 90	Bolos de NaCl 0,9%	1.000 ml en 30 min hasta PAM ≥ 65

REGLA DE ORO **Suero fisiológico antes que insulina** — 1.000–1.500 ml en la primera hora

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La piedra angular y primera medida absoluta en el manejo de toda crisis hiperglicémica aguda es la fluidoterapia endovenosa vigorosa. El EUNACOM insiste sistemáticamente en evaluar que el médico priorice la hidratación con solución salina isotónica antes de cualquier administración de insulina, calcule correctamente el sodio corregido para definir la transición a solución salina hipotónica al 0.45%, y sobre todo, reconozca el momento exacto en que DEBE adicionarse suero glucosado (cuando la glicemia cae a ≤ 200 mg/dL en CAD o ≤ 300 mg/dL en EHH) para permitir que la infusión de insulina continúe activa hasta el cierre del Anion Gap.

TABLA 4.2.B · MONITOREO HÍDRICO Y ELECTROLÍTICO HORARIO EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO

PARÁMETRO	FRECUENCIA DE CONTROL	META TERAPÉUTICA	AJUSTE INMEDIATO SI FALLA
Glicemia capilar	Cada 1 hora	Descenso de 50 a 75 mg/dL/hora	Si baja < 50 mg/h: subir insulina; si baja > 100: bajar
Electrolitos plasmáticos (Na, K, Cl)	Cada 2 a 4 horas	K entre 4.0 y 5.0 mEq/L; Na corr estable	Ajustar aporte de KCl en matraces de fluidos
Gases venosos (pH, HCO3, Anion Gap)	Cada 2 a 4 horas	Aumento de HCO3 > 1-2 mEq/h; cierre Anion Gap	Continuar infusión de insulina y SG 5% hasta resolución
Diuresis horaria (catéter vesical)	Horaria estricta	> 0.5 ml/kg/hora (> 30-50 ml/h)	Si oliguria: verificar volemia o descartar NTA

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **65–68** (pág. 17) · solucionario págs. 30–31.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

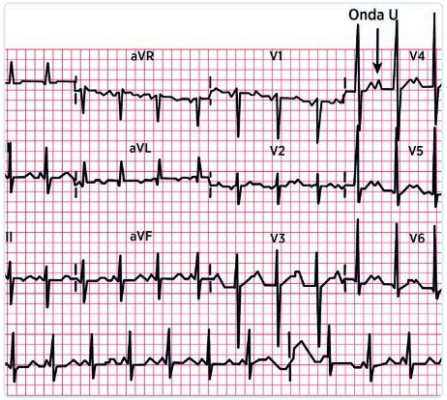
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria

1.02.2.002	Cetoacidosis	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar
1.02.2.007	Síndrome hiperosmolar no cetósico	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.09.2.006	Hipokalemia	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.4.009	Electrocardiograma	Realiza, interpreta y emplea		

LO QUE TE PREGUNTAN

- Si la potasemia es < **3.3 mEq/L**, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere dicho umbral.
- Si el potasio está entre 3.3 y **5.2 mEq/L**, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de solución de hidratación.
- El bicarbonato de sodio está estrictamente restringido a pacientes con acidosis extrema con pH < 6.90.
- Administrar bicarbonato con pH **≥ 6.90 empeora** la hipokalemia, produce acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retrasa la curación.
- La tasa de infusión de insulina cristalina de elección es de **0.1 UI**/kg/hora por vía endovenosa continua.



ONDA U
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 22

ALGORITMO · CETOACIDOSIS: POTASIO, INSULINA Y BICARBONATO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

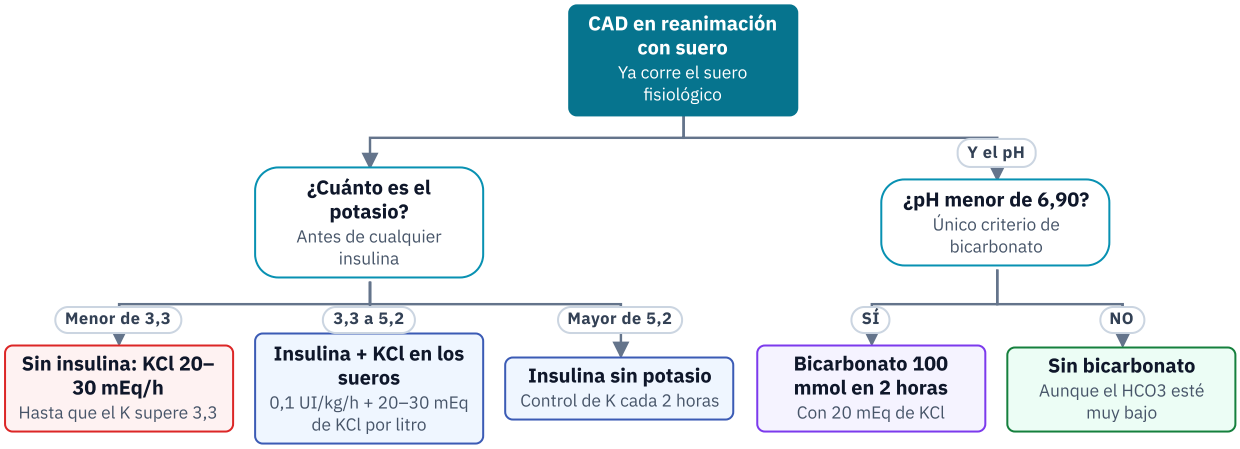


TABLA 4.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL POTASIO PLASMÁTICO DURANTE LA INSULINOTERAPIA EN CAD

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-17

POTASEMIA MEDIDA (K+)	CONDUCTA CON LA INSULINA	APORTE DE CLORURO DE POTASIO (KCL)	OBJETIVO CLÍNICO
< 3.3 mEq/L (Hipokalemia severa)	¡NO INICIAR o SUSPENDER de inmediato!	Infundir 20 a 30 mEq/hora de KCl hasta K > 3.3	Prevenir paro cardíaco en diástole o arritmias fatales
3.3 a 5.2 mEq/L (Rango óptimo)	Iniciar o mantener a 0.1 UI/kg/hora	Agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de hidratación	Mantener potasemia estable entre 4.0 y 5.0 mEq/L
> 5.2 mEq/L (Hiperkalemia)	Iniciar insulina a 0.1 UI/kg/hora	NO aportar potasio; controlar cada 2 horas	Permitir que la insulina baje el potasio a rango normal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-17

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
K menor de 3,3 mEq/L	Suspender insulina; KCl 20–30 mEq/h	Iniciar insulina y reponer K después
K mayor de 5,2 mEq/L	Insulina sin K; control cada 2 h	Tratar la hiperkalemia con calcio
Glicemia no baja 50 mg/dL en la 1ª hora	Duplicar la infusión	Esperar otra hora igual

REGLA DE ORO **Siempre hay déficit total** — Aunque la potasemia sea normal o alta

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **69–70** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

Clase 4.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus

1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

1.02.2.007 Síndrome hiperosmolar no cetósico — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La CAD está resuelta cuando**: Glicemia < **200 mg/dL** Y al menos 2 criterios entre pH > 7.30, HCO3 **≥ 18 mEq/L** y Anion Gap **≤ 12 mEq/L**.
- El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el paciente está lúcido.
- La vida media de la insulina cristalina por vía endovenosa es de solo **5 a 9 minutos**.
- La insulina basal subcutánea debe inyectarse **1 a 2 horas** ANTES de apagar la bomba de infusión continua endovenosa.
- Apagar la bomba en el momento exacto del pinchazo subcutáneo genera un periodo de carencia insulínica que reactiva la cetoacidosis en pocas horas.
- El traslape debe coincidir preferentemente con una comida principal (desayuno o almuerzo) para evaluar la tolerancia digestiva.

ALGORITMO · CAD EN TRATAMIENTO: ¿SE PUEDE APAGAR LA BOMBA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

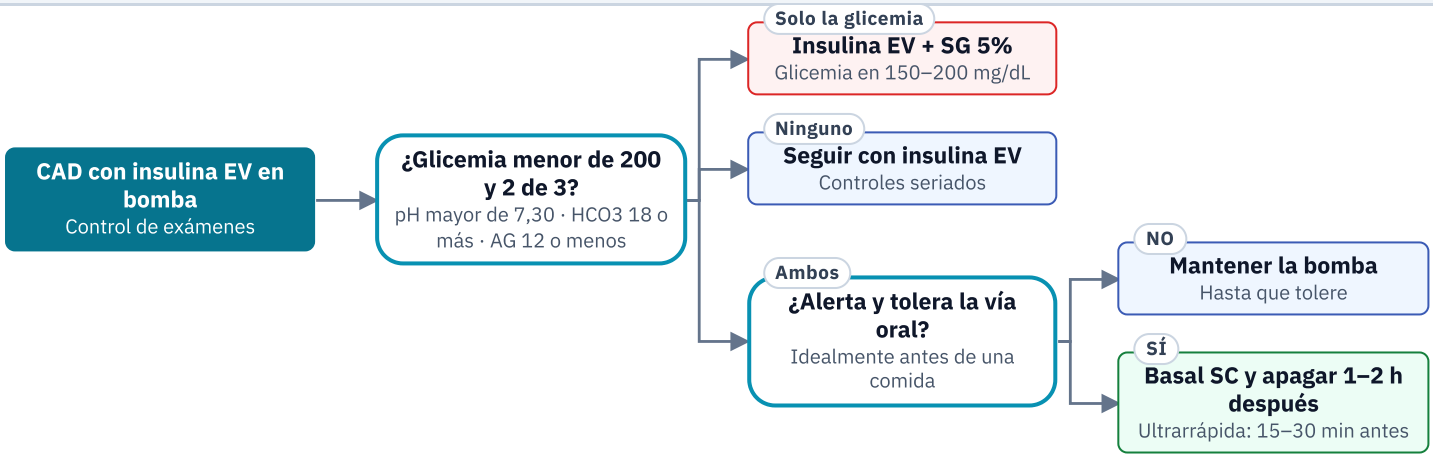


TABLA 4.4 · CRITERIOS DE RESOLUCIÓN Y REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLAPE

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-18

PARÁMETRO	CRITERIO DE RESOLUCIÓN CAD	CRITERIO DE RESOLUCIÓN EHH	REGLA DE ORO EN EL TRASLAPE
Glicemia	< 200 mg/dL	< 250 – 300 mg/dL	Mantener en 150-200 mg/dL con SG 5% hasta resolución
pH Venoso / Arterial	pH venoso > 7.30 (arterial > 7.35)	pH > 7.30	No suspender bomba si pH < 7.30 aunque glicemia sea normal
Bicarbonato Sérico	≥ 18 mEq/L	> 18 mEq/L	El bicarbonato normal es el mejor marcador de recuperación
Anion Gap	≤ 12 mEq/L (Normalizado)	Normal	Confirma que los cetoácidos circulantes han sido eliminados
Osmolaridad Efectiva	Normal (< 300 mOsm/kg)	< 315 mOsm/kg	Correlaciona con el despertar neurológico
Momento de Suspensión EV	1 a 2 horas tras la inyección basal SC	1 a 2 horas tras la inyección basal SC	¡NUNCA apagar la bomba EV simultáneamente con el pinchazo SC!

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-18

PARÁMETRO	RESOLUCIÓN CAD	RESOLUCIÓN EHH	REGLA EN EL TRASLAPE
pH	Venoso mayor de 7,30	Mayor de 7,30	No apagar con pH menor de 7,30

REGLA DE ORO **CAD: glicemia menor de 200 + 2 de 3** — pH mayor de 7,30 · HCO3 18 o más · AG 12 o menos

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **71–72** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

Alta · Edema cerebral en pediatría/adolescentes y reposición de fosfato en debilidad muscular

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Vital

1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

1.02.2.007 Síndrome hiperosmolar no cetósico — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (**60–90%** de la mortalidad pediátrica).
- Ocurre típicamente a las **4–12 horas** de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis parecen estar mejorando.
- **La Tríada de Cushing consiste en**: Bradicardia + Hipertensión arterial + Depresión respiratoria o neurológica.
- **¡REGLA VITAL!**: El tratamiento con Manitol al **20%** o Solución Salina Hipertónica al **3%** se inicia INMEDIATAMENTE ante la sospecha clínica, SIN ESPERAR TAC.
- La hipofosfemia severa (< **1.0 mg/dL**) produce debilidad de la musculatura respiratoria diafragmática e imposibilidad de destete ventilatorio.
- Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de **75–100 mg/dL** por hora.

ALGORITMO · DETERIORO DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA CAD

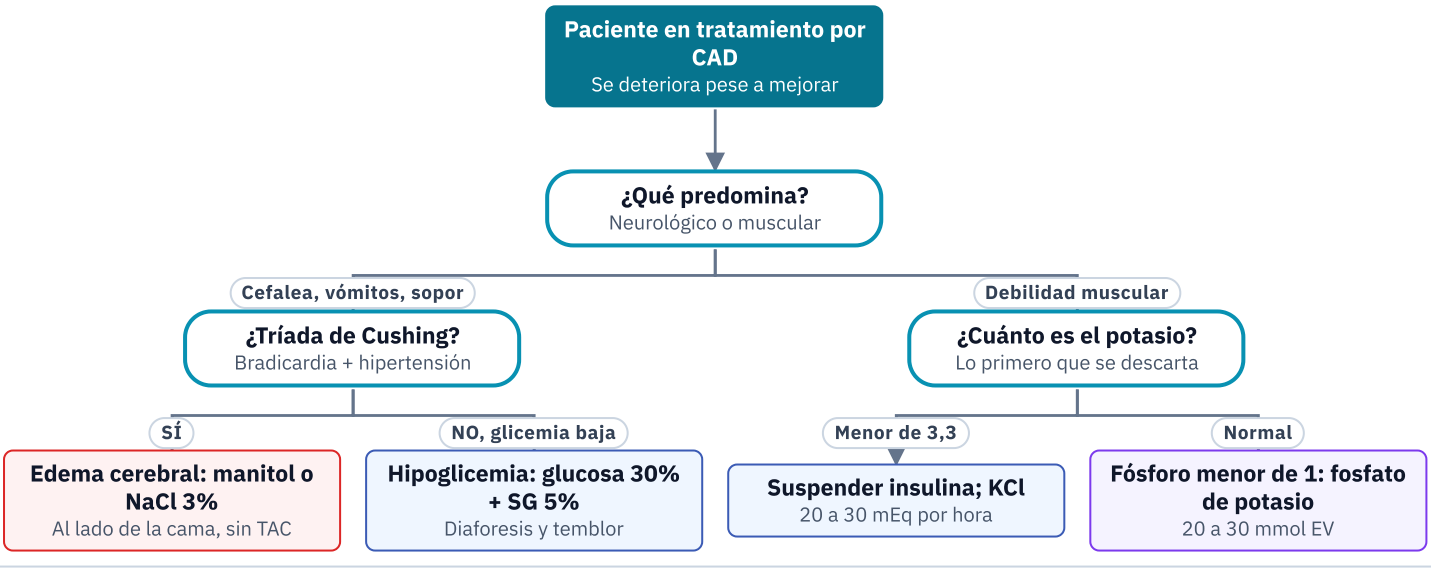


TABLA 4.5 · COMPLICACIONES GRAVES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERGLICÉMICAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-19

COMPLICACIÓN IATROGÉNICA	MECANISMO GATILLANTE	SIGNOS CLÍNICOS CLAVE	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Edema Cerebral Agudo	Descenso osmolar brusco por exceso de fluidos hipotónicos o caída rápida de glicemia	Cefalea intensa, bradicardia, vómitos, hipertensión, sopor	Manitol 20% (0.5-1 g/kg) o NaCl 3% (5 ml/kg) inmediato al lado de la cama
Hipokalemia Severa	Administración de insulina sin chequear K+ o sin aporte de mantención	Debilidad muscular, parálisis flácida, onda U en ECG, arritmias ventriculares	Suspender insulina e infundir KCl a 20-30 mEq/h en fluidos
Hipofosfemia Crítica (< 1.0 mg/dL)	Captación intracelular forzada por la insulina y glucosuria previa	Falla ventilatoria por debilidad diafragmática, rabdomiólisis, parestesias	Fosfato de potasio 20 a 30 mmol EV en infusión lenta
Hipoglicemia Severa	No agregar suero glucosado al alcanzar 200 mg/dL manteniendo insulina	Diaforesis, temblor, convulsiones, neuroglucopenia	Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) y adición de SG 5%

REGLA DE ORO **Empeora cuando los exámenes mejoran** — A las 4–12 horas, sobre todo en niños

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Diabetes Mellitus**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 4.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

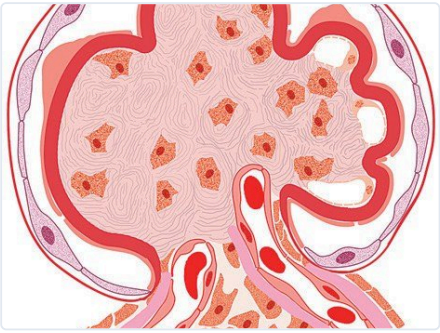
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
9 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y GES Enfermedad Renal Crónica

1.02.1.010	Nefropatía incipiente	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
1.02.4.004	Relación albuminuria / creatininuria	Interpreta y emplea	
1.02.4.019	Microalbuminuria	Interpreta y emplea	
1.09.1.014	Nefropatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	
1.02.1.009	Insuficiencia renal y diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	

LO QUE TE PREGUNTAN

- El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.
- El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los **5 años** del debut en DM1.
- Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y **299 mg**/g en al menos 2 de 3 muestras en **3 a 6 meses**.
- La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.
- Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.



GLOMERULOESCLEROSIS NODULAR
Goljan, Rapid Review Pathology, Link 20-48

ALGORITMO · NEFROPATÍA DIABÉTICA: DEL TAMIZAJE A LA NEFROPROTECCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

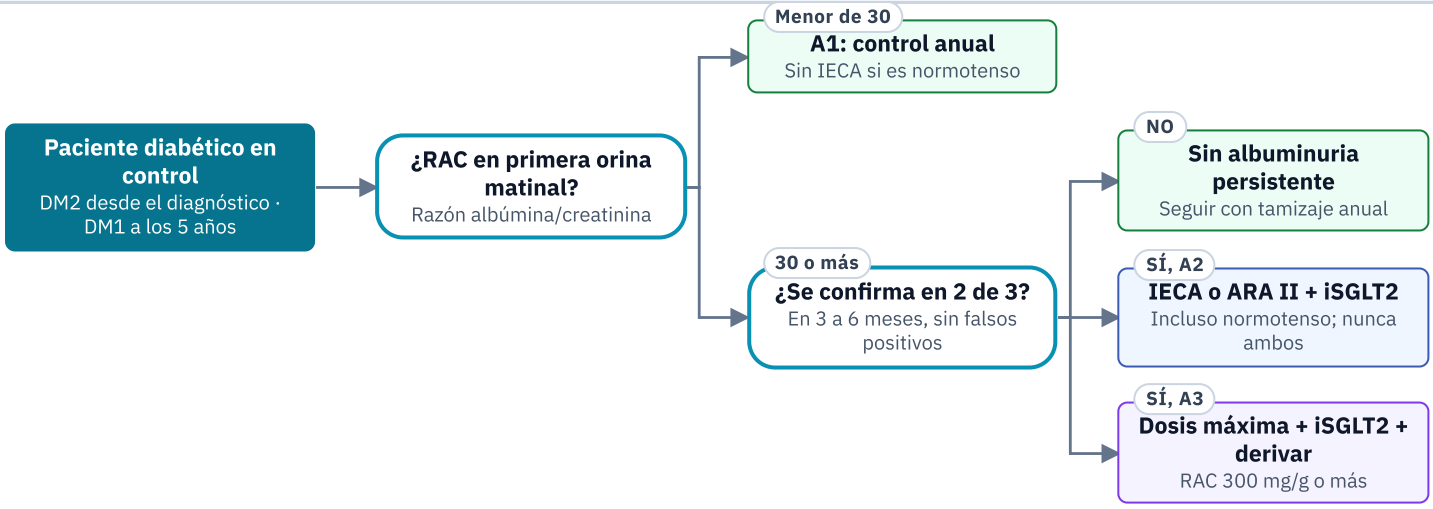


TABLA 5.1 · CATEGORÍAS DE ALBUMINURIA SEGÚN GUÍAS KDIGO Y METAS CLÍNICAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-20

CATEGORÍA KDIGO	RANGO RAC (MG/G)	DENOMINACIÓN CLÁSICA	RIESGO PROGRESIÓN	CONDUCTA FARMACOLÓGICA EUNACOM
A1	< 30 mg/g	Normoalbuminuria	Bajo	Control anual; no requiere IECA si es normotenso
A2	30 – 299 mg/g	Microalbuminuria	Moderado / Alto	INICIAR IECA o ARA II (incluso normotenso) + iSGLT2
A3	≥ 300 mg/g	Macroalbuminuria / Proteinuria	Muy Alto	Titular IECA/ARA2 a dosis máxima + iSGLT2 + Derivar

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-20

CATEGORÍA (RAC)	RIESGO DE PROGRESIÓN	CONDUCTA	ERROR FRECUENTE
Una sola RAC alterada	Aún no se sabe	Repetir: 2 de 3 en 3 a 6 meses	Etiquetar con una muestra
DM2 recién diagnosticada	Puede venir con daño	RAC desde el diagnóstico	Esperar 5 años como en DM1

REGLA DE ORO **DM2 desde el diagnóstico; DM1 a los 5 años** — Luego cada año

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **74–78** (págs. 18–19) · solucionario págs. 31–32.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

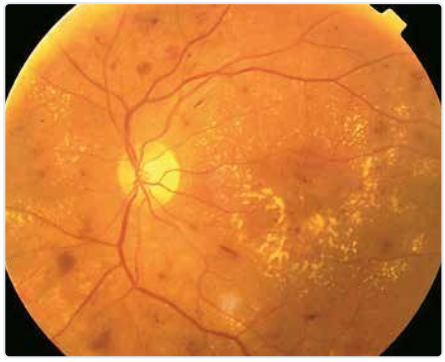
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Retinopatía Diabética (Acceso a tamizaje y fotocoagulación)

1.02.1.015 6.02.1.023	Retinopatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.02.5.003	Fondo de ojo		Realizar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS.
- La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).
- El tratamiento estándar para la Retinopatía Proliferativa es la PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (garantizada por el GES).
- La pérdida súbita e indolora de la visión con abolición del reflejo rojo en un paciente diabético orienta de inmediato a HEMORRAGIA VÍTREA.



HEMORRAGIAS Y EXUDADOS DUROS
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 67

ALGORITMO · RETINOPATÍA DIABÉTICA: DEL TAMIZAJE AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

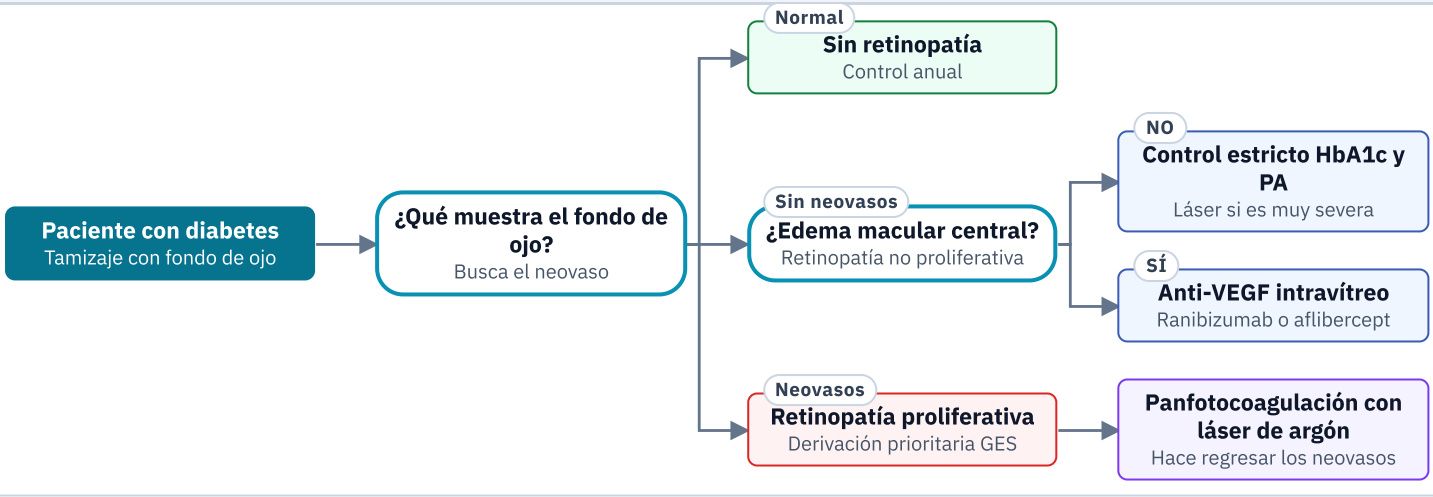


TABLA 5.2 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA Y PROLIFERATIVA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-21

CARACTERÍSTICA	RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP)	RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP)
Signo Patognomónico	Microaneurismas y exudados duros/algodonosos	NEOVASOS (retinianos o en papila óptica)
Lesión más precoz	Microaneurismas capilares (puntos rojos temporales)	Surge tras isquemia retiniana extensa y prolongada
Mecanismo de daño visual	Edema macular diabético secundario	Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional, neovasos
Tratamiento Oftalmológico	Control glicémico/PA estricto; Anti-VEGF si edema macular	PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (GES)
Derivación GES	Prioridad electiva según severidad	DERIVACIÓN URGENTE A OFTALMOLOGÍA (plazo GES 30-60 días)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-21

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
¿Qué define la proliferativa?	Neovasos en papila o retina	Muchas hemorragias o exudados
Exudado algodonoso	Microinfarto por isquemia	Confundirlo con fuga lipídica
DM2 recién diagnosticada	Fondo de ojo de inmediato	Esperar 5 años como en DM1

REGLA DE ORO **Lesión más precoz: microaneurismas** — Por pérdida de pericitos

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **79–81** (pág. 19) · solucionario pág. 32.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS TIER 3

5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

Máxima · Tamizaje con monofilamento de 10 g, clasificación de Wagner, prueba de estilete óseo y criterios de hospitalización/amputación

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
5 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus (Canasta Integral de Curaciones y Manejo de Pie Diabético)

1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.1.011	Neuropatía diabética	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.5.001	Curaciones básicas del pié diabético	Realizar		
4.01.1.051	Pie diabético	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

+ 4 códigos relacionados: 1.02.1.019 · 1.02.3.009 · 1.02.4.001 · 1.02.4.008

LO QUE TE PREGUNTAN

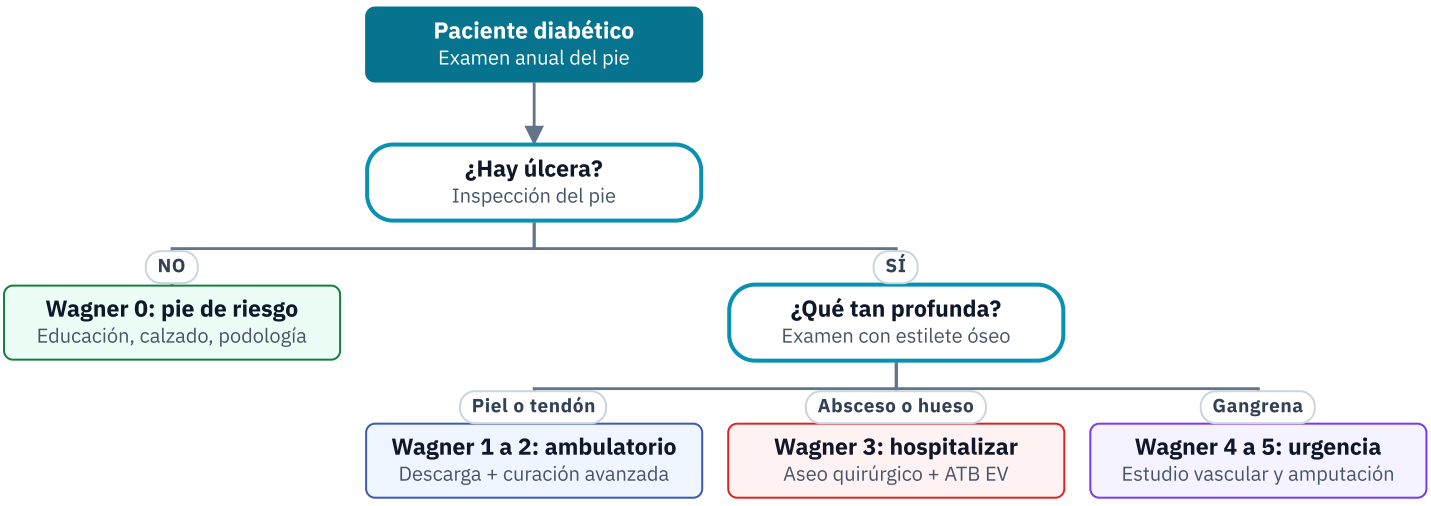
- El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la sensibilidad protectora en APS.
- La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas de apoyo y está rodeada de un grueso borde hiperqueratósico.
- La prueba del estilete óseo positiva ("probe-to-bone") confirma osteomielitis con más del **90%** de especificidad y clasifica la lesión como Wagner 3.
- Wagner 1 es úlcera superficial dérmica; Wagner 2 llega a tendón sin absceso; Wagner 3 tiene osteomielitis o absceso; Wagner 4 tiene gangrena localizada y Wagner 5 gangrena extensa.
- Todo pie diabético con Wagner 3, 4 o 5 requiere HOSPITALIZACIÓN URGENTE para desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.
- La medida terapéutica no quirúrgica más importante para permitir la cicatrización de una úlcera plantar es la DESCARGA DE PRESIÓN ("off-loading").
- No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo debe ser de tejido profundo o biopsia ósea en pabellón.



PIE NEUROPÁTICO EN GARRA
Open-i (NLM), CC BY

ALGORITMO · PIE DIABÉTICO: DEL TAMIZAJE A LA HOSPITALIZACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **73, 82–85** (págs. 18–20) · solucionario págs. 31, 33.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE WAGNER PARA PIE DIABÉTICO Y ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-22

GRADO WAGNER	DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA LESIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA MANDATORIA
Grado 0	Pie de riesgo, piel intacta, callosidades y deformidades	Ambulatorio (APS)	Educación, calzado adecuado, recorte podológico de hiperqueratosis
Grado 1	Úlcera superficial sin compromiso de tendón ni hueso	Ambulatorio (APS)	Descarga de apoyo ("off-loading") + Curación avanzada no adherente
Grado 2	Úlcera profunda que expone tendón o cápsula sin absceso	Ambulatorio / Especialidad	Descarga + Desbridamiento tisular + Curación con alginato
Grado 3	Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o flemón	Hospitalario (Urgencia)	HOSPITALIZAR + Cirugía (drenaje/ostectomía) + ATB EV 4-6 semanas
Grado 4	Gangrena localizada en dedos o talón (isquemia focal)	Hospitalario (Pabellón)	Hospitalizar + AngioTAC/Revascularización + Amputación menor
Grado 5	Gangrena extensa de todo el pie con compromiso sistémico	Hospitalario (Pabellón)	Hospitalización de urgencia vital + Amputación mayor (bajo/sobre rodilla)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-22

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Tamizaje anual de neuropatía	Monofilamento de 10 g	Electromiografía anual
Pie de riesgo sin úlcera (Wagner 0)	Educación, calzado, podología	Derivar a urgencia
Estilete toca hueso	Wagner 3: hospitalizar	Curación ambulatoria

REGLA DE ORO **Monofilamento de 10 g** — Un punto no percibido: pie de alto riesgo

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El pie diabético es una de las complicaciones más costosas y discapacitantes de la medicina. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria el tamizaje de la neuropatía sensitiva con el monofilamento de Semmes-Weinstein (10 gramos), la correcta estadificación según la Clasificación de Wagner (del grado 0 al 5), la técnica semiológica del estilete óseo ("probe-to-bone test") para el diagnóstico de osteomielitis subyacente, y las indicaciones categóricas de hospitalización, desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.

TABLA 5.3.B · ESQUEMA ANTIMICROBIANO ESCALONADO EN INFECCIONES DE PIE DIABÉTICO

SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN	MICROORGANISMOS SOSPECHADOS	ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO	VÍA Y DURACIÓN
Leve (Celulitis < 2 cm, superficial)	Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.	Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cloxacilina 500 mg c/6h VO	Vía oral por 7 a 14 días
Moderada (Celulitis > 2 cm, absceso local)	Polimicrobiana: Gram (+), Gram (-) y anaerobios	Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h VO o Ciprofloxacino + Clindamicina	Vía oral por 14 a 21 días
Severa (Compromiso sistémico / Wagner 3-5)	Polimicrobiana grave con Pseudomonas y bacteriemia	Ceftriaxona 1-2 g/d EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV (o Piperacilina/Tazobactam)	Vía endovenosa hospitalizada
Osteomielitis Comprobada (Wagner 3)	Staphylococcus aureus y bacilos Gram negativos	Según cultivo de biopsia ósea; Ciprofloxacino + Clindamicina o Cefazolina	Vía parenteral inicial, duración total 4 a 6 semanas

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **73, 82–85** (págs. 18–20) · solucionario págs. 31, 33.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
12 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud: Prevención Secundaria Cardiovascular e Hipertensión Arterial / DM

1.02.1.007 1.01.1.005	Dislipidemias	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
1.02.3.013	Riesgo cardiovascular global	Conocimiento general	
1.02.4.021 2.01.4.019 1.01.4.013	Perfil lipídico	Interpreta y emplea	
2.01.1.002	Dislipidemias	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.02.3.007	Prevención de dislipidemias	Conocimiento general	
1.09.3.002	Control de factores de riesgo de enfermedad vascular	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo Cardiovascular Muy Alto.
- La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < **70 mg/dL** (o < **55 mg/dL**); en Riesgo Alto es < **100 mg/dL** (o < **70 mg/dL**).
- Las estatinas de alta intensidad son Atorvastatina **40–80 mg**/día y Rosuvastatina **20–40 mg**/día (reducen el LDL en **≥ 50%**).
- El efecto adverso más frecuente son las mialgias; ante su sospecha, se debe solicitar Creatina Kinasa (CK).
- La rabdomiólisis cursa con CK > **10 veces** el límite superior normal, mioglobinuria y falla renal aguda.

ALGORITMO · DISLIPIDEMIA: DEL RIESGO A LA ESTATINA

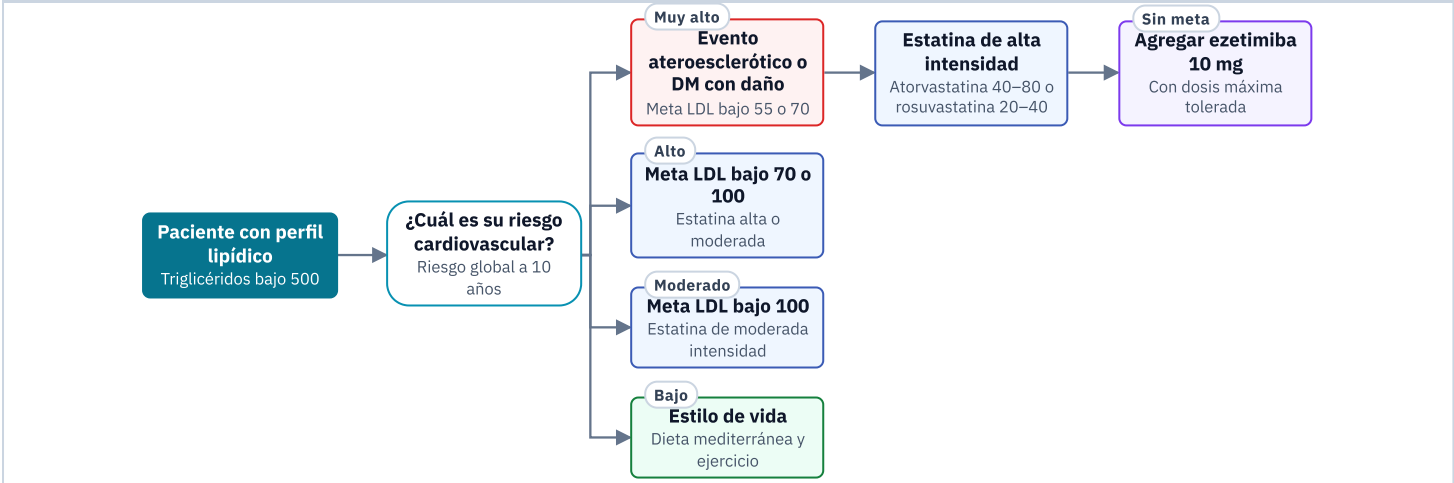


TABLA 5.4 · CLASIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE LAS ESTATINAS Y METAS DE C-LDL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR

CATEGORÍA DE RIESGO	DEFINICIÓN CLÍNICA EUNACOM	META DE COLESTEROL LDL	RÉGIMEN DE ESTATINAS INDICADO
Riesgo Muy Alto	Antecedente de IAM, ACV, claudicación intermitente, DM2 con proteinuria	< 55 mg/dL (o < 70 mg/dL)	Alta intensidad: Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg
Riesgo Alto	DM2 sin daño de órgano blanco > 10a, ERC etapa 3a, Framingham ≥ 10%	< 70 mg/dL (o < 100 mg/dL)	Alta o moderada intensidad: Atorvastatina 20-40 mg
Riesgo Moderado	DM2 joven < 10a sin daño, pacientes con Framingham 5-9%	< 100 mg/dL	Moderada intensidad: Atorvastatina 10-20 mg o Simvastatina 20-40 mg
Riesgo Bajo	Score de Framingham < 5% sin comorbilidades mayores	< 116 mg/dL (o < 130 mg/dL)	Cambios terapéuticos del estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio)

TRAMPAS EUNACOM

clase diab-23

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
IAM previo, LDL 118 con atorvastatina 10 mg	Subir a atorvastatina 40–80 mg	Mantener porque el colesterol total es menor de 200
Prevención secundaria	Estatina de alta intensidad	Rosuvastatina 10 o simvastatina: moderadas

REGLA DE ORO **Evento previo = riesgo muy alto** — IAM, ACV, AIT, arteriopatía periférica

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **86–87** (pág. 20) · solucionario pág. 33.

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

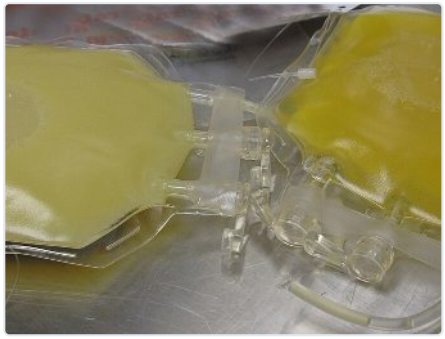
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud: Prevención Cardiovascular / Patología de Urgencia

1.02.2.005	Hipertrigliceridemia grave	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.1.007	Dislipidemias	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.3.011	Regímenes dietéticos para dislipidemias	Conocimiento general		

LO QUE TE PREGUNTAN

- Niveles de triglicéridos > **500 a 1.000 mg/dL** confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA.
- Ante triglicéridos > **500-1000 mg/dL**, el fármaco de primera línea de inicio inmediato son los FIBRATOS (Fenofibrato o Gemfibrozilo).
- El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la síntesis hepática de triglicéridos; deben prohibirse.
- La asociación de Gemfibrozilo con Estatinas está CONTRAINDICADA por elevado riesgo de rabdomiólisis fatal; si se requiere combinar, se usa Fenofibrato.
- La presencia de LDL > **190 mg/dL**, xantomas en tendón de Aquiles e infartos precoces en familiares es diagnóstica de Hipercolesterolemia Familiar.



PLASMA LECHOSO
Wikimedia Commons «Lipemic plasma.jpg», CC BY-SA 3.0, DiverDave

ALGORITMO · DISLIPIDEMIA SEVERA: QUÉ TRATAR PRIMERO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

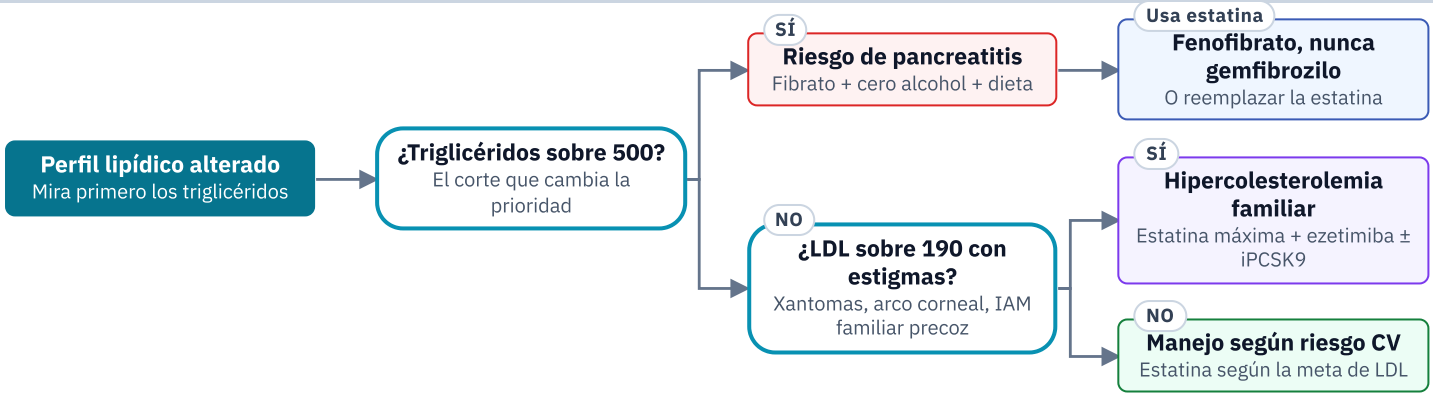


TABLA 5.5 · CLASIFICACIÓN DE HIPERTRIGLICERIDEMIA Y RIESGO DE PANCREATITIS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-24

NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS	CATEGORÍA CLÍNICA	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
150 – 199 mg/dL	Límite Alto	Riesgo cardiovascular moderado	Estilo de vida, dieta baja en azúcares simples
200 – 499 mg/dL	Moderadamente Alto	Ateroesclerosis acelerada	Estatinas si riesgo RCV alto + estilo de vida
500 – 999 mg/dL	Severo	Riesgo inminente de Pancreatitis Aguda	FIBRATO (Fenofibrato 160 mg o Gemfibrozilo) urgente
≥ 1.000 mg/dL	Crítico / Muy Severo	ALTO RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA Y QUILOMICRONEMIA	FIBRATO inmediato + Cero alcohol + Dieta cero grasa (< 15%)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase diab-24

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
TG bajo 500 con LDL alto	Estatina	Fibrato
TG severos en usuario de estatina	Cambiar a gemfibrozilo, o usar fenofibrato si hay que combinar	Agregar gemfibrozilo a la estatina
LDL sobre 190, xantomas de Aquiles, padre con IAM joven	Hipercolesterolemia familiar	Hiperlipidemia combinada o disbetalipoproteinemia

REGLA DE ORO **TG sobre 500–1.000** — Prioridad: evitar la pancreatitis

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **88–90** (pág. 20) · solucionario pág. 34.

Clase 5.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS TIER 3

5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

Alta · obesidad con resistencia a la insulina que solo requiere estilo de vida, acantosis nigricans como marcador, prevención de DM2 en prediabetes y realimentación gradual en anorexia nerviosa

1.02.1.012	Obesidad	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.013	Obesidad mórbida	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.1.016 1.01.1.023	Síndrome metabólico	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.018	Trastornos de conducta alimentaria	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.02.3.001 1.01.3.001	Alimentación saludable	Conocimiento general		

+ 7 códigos relacionados: 1.02.3.002 · 1.02.3.006 · 1.02.3.012 · 1.02.3.014 · 1.02.4.012 · 1.02.4.020 · 1.01.3.004

LO QUE TE PREGUNTAN

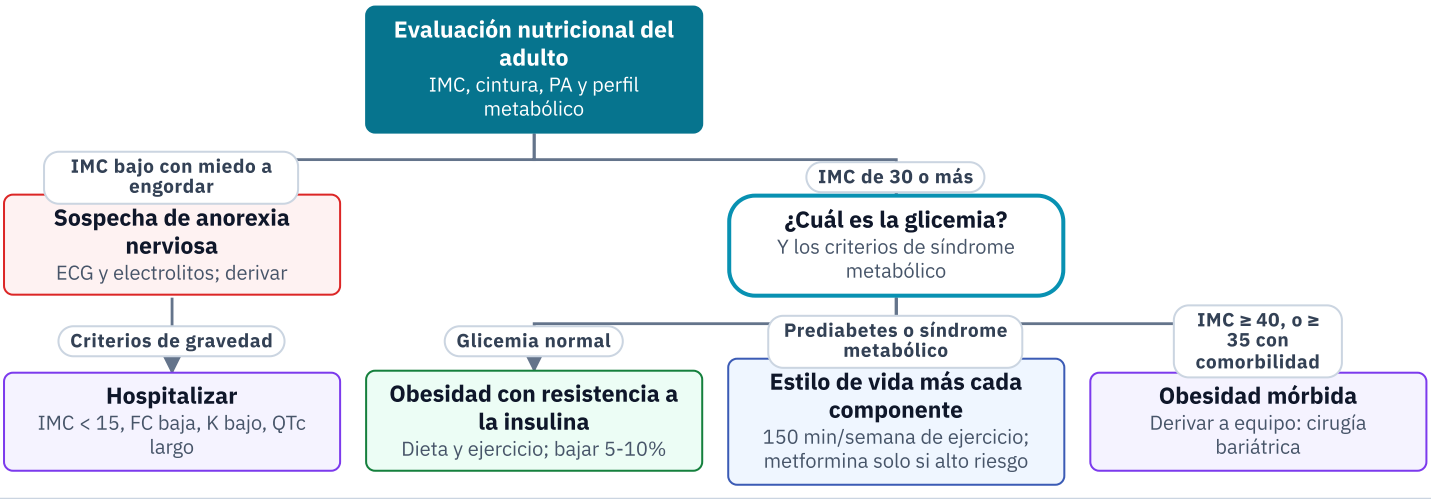
- **IMC = peso / talla²**: bajo peso < 18.5, sobrepeso 25–29.9, obesidad **≥ 30 y** obesidad mórbida **≥ 40** (o **≥ 35 con** comorbilidad); la cintura **≥ 102 cm** en hombres o **≥ 88 cm** en mujeres define obesidad abdominal.
- **Balance nitrogenado** = proteínas ingeridas / 6.25 − (NUU de **24 horas** + **4 g**); un NUU > **10 g**/día indica estrés metabólico severo y un balance negativo exige aumentar el aporte proteico-calórico.
- El obeso con glicemia normal y resistencia a la insulina solo requiere dieta y ejercicio; no se indica metformina ni insulina. La meta es bajar **5–10%** del peso en **6 meses**.
- El síndrome metabólico requiere 3 de 5 criterios (cintura, TG **≥ 150, HDL** bajo, PA **≥ 130/**85 y glicemia **≥ 100**); la acantosis nigricans es marcador de resistencia a la insulina y el tratamiento es el de cada componente más estilo de vida.
- Para prevenir la DM2 en prediabetes la intervención más importante es el estilo de vida (baja de peso y **150 minutos** semanales de ejercicio; reduce **58%** la progresión); la metformina es de segunda línea.
- **Anorexia nerviosa**: realimentar con 10–15 kcal/kg/día y tiamina, vigilando fósforo, potasio y magnesio, para prevenir el síndrome de realimentación; hospitalizar según IMC, FC, PA y electrolitos y derivar a equipo especializado.



MANGA GÁSTRICA
Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3 (esquema)

ALGORITMO · EVALUACIÓN NUTRICIONAL: OBESIDAD, SÍNDROME METABÓLICO Y TCA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **1–5, 55** (págs. 8–9, 16) · solucionario págs. 21, 29.

Clase 5.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 5.6 · CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO SEGÚN IMC Y CONDUCTA INICIAL = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DIAB-25

IMC (KG/M²)	CATEGORÍA	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL	CONDUCTA INICIAL
< 18.5	Bajo peso	Desnutrición, TCA, enfermedad consuntiva	Estudiar causa; si hay miedo a engordar sospechar anorexia nerviosa y derivar
18.5 – 24.9	Normal	Riesgo habitual	Mantener alimentación saludable y ejercicio
25 – 29.9	Sobrepeso	Riesgo cardiometabólico aumentado	Estilo de vida; tamizar glicemia y perfil lipídico
30 – 34.9 / 35 – 39.9	Obesidad grado I / II	DM2, HTA, dislipidemia, apnea del sueño	Déficit calórico y ejercicio; fármacos si hay fracaso; tratar comorbilidades
≥ 40 (o ≥ 35 con comorbilidad)	Obesidad mórbida	Mortalidad cardiovascular y metabólica elevada	Derivar a equipo para evaluar cirugía bariátrica

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA clase diab-25

IMC	RIESGO PRINCIPAL	CONDUCTA INICIAL
Prediabetes en riesgo de DM2	Progresión a diabetes	Ejercicio 150 min/semana y bajar peso
Acantosis nigricans	Resistencia a la insulina	Buscar prediabetes, dislipidemia e HTA

REGLA DE ORO **IMC por tramos, cintura aparte** — Mórbida: ≥ 40, o ≥ 35 con comorbilidad

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La nutrición clínica reúne tres escenarios de alto rendimiento. El primero es la evaluación nutricional: IMC, circunferencia de cintura, laboratorio (albúmina, prealbúmina) y el balance nitrogenado con nitrógeno ureico urinario de 24 horas para medir el catabolismo. El segundo es el exceso de peso: la obesidad con resistencia a la insulina se maneja con estilo de vida y déficit calórico, el síndrome metabólico se diagnostica con 3 de 5 criterios y se trata en sus componentes, la prediabetes se previene con 150 minutos de ejercicio y baja de peso, y la obesidad mórbida se deriva a cirugía bariátrica. El tercero es el déficit: la anorexia nerviosa exige una realimentación gradual (10 a 15 kcal/kg/día) para evitar el síndrome de realimentación.

PRACTICA **Libro Gordo Diabetes Mellitus**, preguntas **1–5, 55** (págs. 8–9, 16) · solucionario págs. 21, 29.

Clase 5.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES	
1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY	pág. 3
Adulto con sobrepeso u obesidad — Habitualmente sobre **35 a 45 años**	CORTE
1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS	pág. 4
PTGO: **2 horas ≥ 200 mg/dL** — Carga de **75 g** de glucosa	DOSIS
HbA1c **≥ 6,5 %** — Laboratorio estandarizado	CORTE
HOMA-IR > 2,6 — Glicemia × insulina de ayuno / 405	CORTE
1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)	pág. 5
Ayuno **70 a 95 mg/dL** — **1 h** postprandial < 140 · **2 h** < 120	DOSIS
PTGO **75g** a las **2 horas · ≥ 140 mg/dL · ≥ 200 mg/dL**	DOSIS
Nutrición, luego insulina — Ayuno 70–95 · **1 h** < 140	CORTE
1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas	pág. 6
Activo < **7,5 %** · frágil < **8–8,5 %** — En meta: no intensificar	META
HbA1c < **7 %** — Expectativa de vida sobre **15 años**	CORTE
Presión arterial < 130/**80 mmHg** — Si es bien tolerada	CORTE
1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular	pág. 7
150 minutos semanales — **≥ 3 días**, fuerza **2 a 3 veces**	CORTE
150 minutos a la semana — Intensidad moderada	TIEMPO
BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS	
2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL	pág. 8
Falla de biterapia máxima — NPH nocturna **0,2 UI**/kg	DOSIS
500 u **850 mg** una vez al día — Con la comida principal	DOSIS
Subir cada **1 a 2 semanas** — Hasta **1.700 a 2.550 mg**/día	DOSIS
2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas	pág. 9
VFG 30 a 44: máx. **1.000 mg** — VFG < 30: suspender (acidosis láctica)	DOSIS
Falla renal — VFG 30 a 44: precaución · VFG < 30: contraindicada	CORTE
Neutra o baja **1 a 2 kg** — Ideal en el obeso	CORTE
2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4	pág. 10
Cetoacidosis euglicémica — Glicemia < **200 a 250 mg/dL**	DOSIS
Potencia moderada — HbA1c **–0,5 a 0,7 %**	CORTE
IAM o ACV previo, obesidad — Baja de peso **5 a 15 %**	CORTE
2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	pág. 11
Más del **20 %** fuera de meta — O CA fetal ≥ p75–90	META
A las 3 AM: > **60 mg/dL** — Descartar hipoglicemia nocturna	DOSIS
1 h postprandial: < **140 mg/dL** — O **2 h** postprandial: < 120	DOSIS
2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal	pág. 12
PA < 130/**80 mmHg** — Biterapia si parte **≥ 140**/90	CORTE
IECA o ARA-II + amlodipino — Amlodipino **5 a 10 mg**/día	DOSIS
BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO	
3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio	pág. 13
NPH bedtime + metformina — **10 UI** o **0,1–0,2 UI**/kg	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria (cont.)	pág. 30
NPH: peak **4–10 h** — Siempre al acostarse	TIEMPO
Catabolismo o HbA1c **≥ 9–10 %** — Aunque sea obeso o recién diagnosticado	CORTE
3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis	pág. 14
+**2 UI** si 131–180 · +**4 UI** si > 180 — Hipoglicemia: bajar **10–20 %**	DOSIS
3 AM < 70: Somogyi → BAJAR — 3 AM > 100: alba → SUBIR	CORTE
Consultar si < 70 o dos valores > 250 — Lectura discordante: repetir	CORTE
3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado	pág. 16
< **110 mg/dL**: más muertes — Evidencia del ensayo NICE-SUGAR	DOSIS
140 a 180 mg/dL — En UCI y en sala	DOSIS
0,2 a 0,4 UI/kg/día — Insulina subcutánea total	DOSIS
3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate	pág. 17
Glicemia < **70 mg/dL** — Valor de alerta	DOSIS
Glicemia < **54 mg/dL** — Empiezan los síntomas neuroglucopénicos	DOSIS
BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS	
4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)	pág. 18
Glicemia > **600 mg/dL** — Frecuente 800 a 1.200	DOSIS
Glicemia > **250 mg/dL** — Típicamente entre 300 y 600	DOSIS
4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH	pág. 19
Bolos de **1.000 ml** en **30 min** — Hasta PAM **≥ 65 mmHg**	DOSIS
Diuresis horaria — > **0,5 ml/kg**/h · catéter vesical	DOSIS
4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato	pág. 21
0,1 UI/kg/h — Con o sin bolo de **0,1 UI**/kg	DOSIS
K < 3,3 o U con arritmia — Potasio antes de la insulina	CORTE
4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea	pág. 22
Glicemia menor de **200 mg/dL** — Necesaria, pero no basta	DOSIS
Bicarbonato **18 mEq/L** o más — El mejor marcador de recuperación	CORTE
4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia	pág. 23
Menor de **5 años** o debut de DM1 — El grupo más expuesto	CORTE
Fósforo menor de **1,0 mg/dL** — Falla ventilatoria: fosfato de potasio EV	DOSIS
BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS	
5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector	pág. 24
A2: RAC de **30 a 299 mg**/g — 2 de 3 muestras en **3 a 6 meses**	DOSIS
DM2: desde el diagnóstico — Y luego cada **12 meses**	TIEMPO
5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES	pág. 25
Mi ojo derecho con su ojo derecho — A **2 cm** y 15° lateral	CORTE
Control: anual, o cada **6 meses** — Embarazo: antes y cada trimestre	TIEMPO
5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico	pág. 26
Normal 0,9 a 1,3 — < 0,9 EAP · < 0,4–0,5 isquemia severa	CORTE
Pulsos ausentes, piel fría y atrófica — Relleno capilar > 3 segundos	CORTE
5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas	pág. 28
ERC avanzada — VFG menor de **45 ml**/min	DOSIS
150 min/semana, dieta mediterránea — Sal < **5 g**/día, alcohol limitado	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria (cont.)	pág. 30
Ezetimiba **10 mg**/día — Baja un **15 a 20 %** adicional	DOSIS
5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis	pág. 29
Colesterol < **200–300 mg**/día — Limitar yema de huevo y vísceras	DOSIS
Grasas saturadas < **7–10 %** de las calorías — Trans cerca de cero	CORTE
5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria	pág. 30
HDL < 40 (H) o < **50 mg/dL** (M) — PA **≥ 130/**85 o tratamiento	DOSIS
La meta es bajar **5–10%** del peso en **6 meses**.	META

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)		pág. 5
Pilares · Si no logra metas en 1–2 semanas	**O hay macrosomía: insulina NPH y cristalina**	
2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL		pág. 8
Enfermedad aterosclerótica · Agonista GLP-1	**Liraglutida o semaglutida; o un iSGLT2**	
Garantía GES de diabetes tipo 2 · Canasta	**Metformina y glibenclamida**	Los orales de la canasta
Garantía GES de diabetes tipo 2 · Canasta	**Insulina NPH y cristalina**	Jeringas, lancetas y glucómetro
2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4		pág. 10
Vía de administración	**Liraglutida**	Subcutánea diaria
Vía de administración	**Semaglutida**	Subcutánea semanal u oral diaria
2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante		pág. 11
Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	**La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.**	
2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal		pág. 12
La combinación prohibida · Riñón avanzado	**Segundo fármaco: furosemida o amlodipino**	
Biterapia de inicio	**O IECA o ARA-II + tiazida**	Hidroclorotiazida o indapamida
3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis		pág. 14
Cálculo fino y educación · En DM1 intensificada	**Ratio insulina:carbohidratos**	Regla del 500: 500 / dosis total diaria
3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado		pág. 16
Dosis del esquema basal-bolo · Dosis total diaria	**Insulina subcutánea total**	
4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato		pág. 21
La pauta de la bomba · Qué y cómo	**Insulina cristalina en infusión continua**	CAD moderada a severa y EHH
5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES		pág. 25
Tratamientos GES · Anti-VEGF intravítreo	**Ranibizumab, aflibercept: edema macular central**	
5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico		pág. 26
Esquema escalonado según la gravedad · Leve	**Cefadroxilo o cloxacilina VO**	**7 a 14 días**
Esquema escalonado según la gravedad · Moderada	**Amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + clindamicina**	**14 a 21 días**
5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas		pág. 28
Alta vs moderada intensidad · Alta intensidad	**Atorvastatina 40 a 80 mg**	O rosuvastatina **20 a 40 mg**
5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis		pág. 29
Intensivo y de por vida	**Estatina de alta potencia a dosis máxima**	+ ezetimiba + inhibidor de PCSK9
5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria		pág. 30
Fármacos y cirugía bariátrica · Farmacoterapia	**Inhibe lipasas · esteatorrea y déficit de vitaminas**	

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
5.6 Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria (cont.)		pág. 30
Fármacos y cirugía bariátrica · Farmacoterapia	**Liraglutida 3 mg, semaglutida 2,4 mg**	

GES de Diabetes Mellitus & Dislipidemias

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2**

Tema **1.1** · Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY
1.02.1.004 · 1.02.1.005
pág. **3**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2 en Personas de 15 años y más**

Tema **1.2** · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS
1.02.1.005 · 1.02.4.024 · 1.02.4.017
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto**

Tema **1.3** · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)
1.02.1.002 · 1.02.1.003 · 3.01.1.004
pág. **5**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **1.4** · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas
1.02.1.005 · 1.02.4.017 · 1.02.3.005
pág. **6**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **1.5** · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular
1.02.3.004 · 1.02.3.003 · 1.02.2.006
pág. **7**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **2.1** · Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL
1.02.1.005 · 1.02.4.017
pág. **8**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **2.2** · Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas
1.02.1.005 · 1.02.2.006 · 1.02.2.001
pág. **9**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Salud del Embarazo y Parto**

Tema **2.4** · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante
1.02.1.002 · 1.02.1.003 · 3.01.1.004
pág. **11**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Hipertensión Arterial Primaria y DM2**

Tema **2.5** · Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal
1.02.1.008 · 1.02.1.010
pág. **12**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1**

Tema **3.1** · Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio
1.02.1.005 · 1.02.1.004
pág. **13**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y Tipo 1**

Tema **3.2** · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis
1.02.1.005 · 1.02.1.004 · 1.02.2.006
pág. **14**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2**

Tema **3.3** · Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado
1.02.1.005 · 1.02.4.015 · 1.02.1.006
pág. **16**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica APS**

Tema **3.4** · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate
`1.02.2.006` · `1.02.4.018` · `1.02.4.015`
pág. **17**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria**

Tema **4.1** · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)
`1.02.2.002` · `1.02.2.007` · `1.02.2.003`
pág. **18**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Médica Hospitalaria**

Tema **4.2** · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH
`1.02.2.002` · `1.02.2.007` · `1.02.2.003`
pág. **19**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Hospitalaria**

Tema **4.3** · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato
`1.02.2.002` · `1.09.2.006` · `1.02.2.007`
pág. **21**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus**

Tema **4.4** · Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea
`1.02.2.002` · `1.02.2.007`
pág. **22**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus / Urgencia Vital**

Tema **4.5** · Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia
`1.02.2.002` · `1.02.2.007`
pág. **23**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus Tipo 2 y GES Enfermedad Renal Crónica**

Tema **5.1** · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector
`1.02.1.010` · `1.09.1.014` · `1.02.4.004`
pág. **24**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Retinopatía Diabética (Acceso a tamizaje y fotocoagulación)**

Tema **5.2** · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES
`1.02.1.015` · `6.02.1.023` · `1.02.5.003`
pág. **25**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 2): Diabetes Mellitus (Canasta Integral de Curaciones y Manejo de Pie Diabético)**

Tema **5.3** · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico
`1.02.1.014` · `1.02.1.011` · `1.02.5.001`
pág. **26**

GES **Garantía Explícita en Salud: Prevención Secundaria Cardiovascular e Hipertensión Arterial / DM**

Tema **5.4** · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas
`1.02.1.007` · `1.02.3.013` · `1.02.4.021`
pág. **28**

GES **Garantía Explícita en Salud: Prevención Cardiovascular / Patología de Urgencia**

Tema **5.5** · Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis
`1.02.2.005` · `1.02.1.007` · `1.02.3.011`
pág. **29**

Sin garantía GES específica (2 temas): 2.3 · 5.6. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **3.3** Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado 16
- ★★★ **1.2** Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS 4
- ★★★ **1.4** Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas 6
- ★★★ **2.1** Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL 8
- ★★★ **2.2** Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas 9

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 13–16, 18–25, 44–45.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **2.3** Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 10
- ★★★ **3.1** Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio 13
- ★★★ **3.2** Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis 14
- ★★★ **1.3** Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) 5

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 17, 26–27, 37–43.

DÍA 3

4 temas · ★★★

- ★★★ **2.4** Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante 11
- ★★☆ **5.4** Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas 28
- ★★☆ **5.1** Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector 24
- ★★☆ **4.2** Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH 19

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 28–29, 65–68, 74–78, 86–87.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.4** Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate 17
- ★★☆ **5.3** Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico 26
- ★★☆ **1.1** Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY 3
- ★★☆ **4.1** Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) 18

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 6–12, 46–54, 56–64, 73, 82–85.

DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **4.3** Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato 21
- ★★☆ **5.6** Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria 30
- ★☆☆ **1.5** Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular 7
- ★☆☆ **4.4** Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea 22

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 1–5, 55, 69–72.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **4.5** Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia 23
- ★☆☆ **5.2** Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES 25
- ★☆☆ **5.5** Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis 29
- ★☆☆ **2.5** Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal 12

Practica: Libro Gordo Diabetes Mellitus, preguntas 30–36, 79–81, 88–90.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 32
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.2 · 1.3 · 1.4 · 2.1 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 3.1 · 3.2 · 3.3
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Diabetes Mellitus en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 10 temas

24 3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado GES 16
21 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS GES 4
19 1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas GES 6
19 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL GES 8
18 2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas GES 9
18 2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 10
18 3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio GES 13
18 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis GES 14
15 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) GES 5
15 2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante GES 11

★★ Prioridad media · 9 temas

12 5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas GES 28
9 5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector GES 24
8 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH GES 19
6 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate GES 17
5 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico GES 26
4 1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY GES 3
4 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) GES 18
4 4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato GES 21
4 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria 30

★ Prioridad baja · 6 temas

3 1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular GES 7
3 4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea GES 22
3 4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia GES 23
1 5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES GES 25
1 5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis GES 29
0 2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal GES 12